

의료시스템과학(HSS) 교육과정 개발 및 적용

1차년도 성과 정리본 · 2025~2026

전국 의과대학이 공동 활용할 수 있도록 건강의 사회적 결정요인과 환자안전을 위한 질 향상 교육의 강의·운영 설계를 개발했습니다.

홈페이지에 공개된 주요 결과와 세부 성과를 모은 자료입니다. 원본 보고서와 구분됩니다.

핵심 성과

16차시 · 설계·강사 배치 확정

14개교 · 참여대학

0건 · 보고 시점 플랫폼 탑재

- SDOH는 5모듈·10차시, QI는 2모듈·6차시로 설계했으며 차시당 25~35분으로 구성했습니다.
- 16차시 강의자료와 영상 제작을 진행하고 K-MedU 표준 개설신청서·모듈계획서 2건을 제출했습니다.
- QI는 SQUIRE 2.0, 플립러닝·TBL, 4시간 압축형·8시간 확장형 트랙과 교수자교육 권장 6시간 설계안을 포함합니다. 교수자교육 영상 실적과는 구분합니다.
- 대외 발표 2회, 공동 워크숍 2일, 뉴스레터 3호를 통해 확산했으며 9개교의 현황을 공유했습니다.
- 공유 교육과정 효과성 평가, 한국형 HSS 개념 정립 델파이, 건양의대 시스템 사고 협력연구 등 연구계획 3건을 정리했습니다.
- 학생 수강·효과성 평가는 보고 시점 이후 과제입니다. 완성 파일이 확인되지 않은 평가도구는 산출물 실적에서 제외했습니다.

주요 산출물

- SDOH·QI 강의 설계 16차시
- 차시별 강의자료 제작
- 공유 교육과정 표준 설계 문서

- 연구계획 3건·뉴스레터 3호

세부 성과 목차

- 01 · 추진 배경 및 이론적 배경
- 02 · 과제 목표 및 성과지표
- 03 · 추진 체계 및 방법
- 04 · 추진 경과 및 실적
- 05 · 주요 결과 및 성과물
- 06 · 성과지표 달성도 및 자체평가
- 07 · 성과 확산 및 활용 방안
- 08 · 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

01 추진 배경 및 이론적 배경

1. 추진 배경 및 필요성

가. 정책·제도적 배경

본 과제는 교육부·한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)의 「의과대학 교육혁신 지원사업(Core Plus)」 세부과제 2-6으로, HSS·시민성 교육·공유 교육과정·디지털 전환·지역기반 교육을 축으로 하는 4대 핵심영역 19개 세부과제 가운데 하나로 배치되었다(2025.7.24 킥오프 회의록). 킥오프 회의에서 확인된 사업의 성격은 명확하였다. 본 사업은 "'연구'보다는 모든 의과대학이 공유 가능한 교육과정, 교재, 동영상, 워크북 등 성과물 개발에 초점"을 두며, 개발된 성과물은 공유 플랫폼에 탑재되어 전국 40개 의과대학이 활용할 수 있어야 한다.

국내 기반은 이미 두 차례의 KAMC 정책연구로 어느 정도 마련되어 있었다. 첫째, 「의료와 사회의 통합적 이해와 실천을 위한 보건의료시스템과학 교육체계 구축 사업」(KAMC, 2021)은 미국 HSS 개념 틀의 한국적 타당성을 검토하여 핵심 영역 7개·기반 역량 영역 4개·연결 영역 1개로 구성된 개념 틀을 국내에 확정하고, 40개 의과대학을 대상으로 한 현황·요구도 조사를 수행하였다. 둘째, 「의료시스템과학 교육 확산을 위한 교수개발 사업」(KAMC, 2023)은 영역별 성과·학습목표·교수학습방법·평가방법을 구체화하고, 교재 번역과 KAMC 홈페이지 기반 공유 플랫폼을 구축하였다.

또한 2021년 정책연구는 HSS 정착과 체계화를 위한 관련 단체의 역할 기대 수준을 조사한 결과 KAMC에 대한 기대가 가장 높았고, 그 내용이 "교육과정 도입 관련 컨센서스 도출과 공론화, 목표 개발, 자원 개발(교수개발, 교육자 양성, 교재 개발, 가이드라인 제공), 교육과정 개발"이었음을 보고하였다. 본 과제는 이 기대에 대한 KAMC 차원의 이행 조치에 해당한다.

나. 현장의 문제 인식 — 여러 과정·교과목에 분산된 HSS 교육 내용

HSS를 구성하는 교육 내용은 국내 의과대학에 이미 존재한다. 다만 하나의 관점으로 묶이지 않은 채 여러 과정·교과목에 분산되어 있다. 채유미 외(2023)가 40개 의과대학 학장 추천 교수 1인을 대상으로 실시하고 23개교(57.5%)가 응답한 조사는 이 파편화의 양상을 구체적으로 보여준다.

- 핵심 7개 영역 중 6개 영역(환자·가족과 지역사회, 의료구조와 과정, 의료정책과 경제, 의료정보과학과 기술의 활용, 인구·공중·사회적 건강결정요인 등)은 17~21개교(73.9~91.3%)에서 이미 교육되고 있었다.
- 반면 가치 기반 의료는 10~19개교, 의료시스템 개선은 8~13개교(34.8~56.5%)에 그쳤다.
- 기반 역량 중 변화관리는 9~14개교(39.1~60.9%), 연결 영역인 시스템 사고는 5~7개교(21.7~30.4%)로 가장 낮았다.
- 핵심 7개 영역을 전 학년에 걸쳐 교육하는 대학은 한 곳도 없었다.

○ 관련 내용은 주로 예방의학, 의료인문학, 의료윤리 교과목에서 다루어지고 있었다.

교육 요구도는 핵심 영역 전반에서 평균 4.0~4.7점(5점 척도)으로 높았으나, 정작 시스템 사고의 개념·중요성 이해 및 임상 적용 항목은 3.7~3.9점으로 상대적으로 낮았다. 가장 부족한 영역이 가장 덜 필요하다고 인식되는 역전 구조가 관찰된 것이다. 자유기술 응답에서는 "현재는 의료시스템과학이라는 개념보다는 보건 의료관리학, 의료정보학, 역학, 임상실습, 지역사회의학 실습에서 단발적으로 이루어지고 있어 체계성을 갖추고 있다고 보기는 어렵다", "학습역량 달성을 위해서는 실제 학생이 참여하는 실습이나 활동이 연계되어야 하는데 상당 부분 강의 수준에 머물러 있다"는 진단이 제시되었다.

같은 문제 의식은 사업팀 내부에서도 반복 확인되었다. 2026년 7월 8일 제4회 교육부 성과공유세미나 대전충청권 HSS포럼에서 최용준 팀장은 "한국에서는 예방 의학·사회의학이 오래전부터 '제3의 기둥'을 자임"해 왔으나 "미국에서 HSS가 메우려던 의학교육의 공백을 채우는 것은 미완의 과제"라고 발제하였다. HSS 교육은 외국 의학교육의 수입이 아니라 국내 관련 분야가 이미 안고 있던 숙제라는 규정이다.

다. 문제 진술 — 축적된 정책연구와 번역에도 현장에 안착하지 못한 이유

2021년 개념 틀, 2023년 교수개발 설계와 교재 번역, KAMC 플랫폼 구축까지 5년간의 축적에도 불구하고 개별 의과대학의 교육과정 안에서 HSS는 여전히 산발적이다. 본 과제는 그 간극의 원인을 개념과 정책이 부족했던 것이 아니라, 각 대학이 바로 교육과정에 투입할 수 있는 실체적 공유 성과물이 없었고 이를 도입할 전략과 계기가 마련되지 않았다는 데 있다고 진단한다. 개별 대학이 단독으로 감당하기 어려운 개발 비용과 교수자 확보 부담이 도입을 지연시켜 온 것이다. 교육부·KAMC 「의과대학 교육혁신 지원사업」은 이 공백에 대한 제도적 계기가 되었다. 협회 차원의 공동 개발과 공유대학 플랫폼이라는 경로가 열리면서, 개별 대학이 각자 개발할 필요 없이 공통 자산을 활용해 도입을 검토할 수 있는 조건이 처음으로 형성되었다.

2025년 10월 1일 3차 전체회의에서 사업팀은 37개 대상 학교 중 26개 학교가 제출한 수정 사업계획서를 분석하였다. 그 결과 HSS를 별도 세부과제로 구성하거나 유의미하게 언급한 학교는 9개교(강원대·건국대·건양대·경북대·동국대·부산대·아주대·울산대·한림대)였다. 그러나 이들 계획서는 대체로 '모듈 개발', '나선형 배치', '평가체계 구축'과 같은 상위 수준의 추진 방향을 기술하는 데 머물렀고, 실제 주차별 차시 구성과 강의 콘텐츠 설계는 공백으로 남아 있었다. 즉 의지와 계획은 여러 대학에 존재하나, 그 계획을 채울 콘텐츠가 없어 진도가 나가지 않는 상태였다.

이 공백은 본 과제가 무엇을 만들어야 하는지를 규정하였다. 대학이 스스로 만들지 못하는 것은 개념 정의가 아니라 25~35분짜리 강의 영상과 그것을 가르칠 교수자다. 따라서 본 과제는 1차년도의 과업 범위를 ① 공유대학(K-MedU) 탑재용 영상 콘텐츠 16개(SDOH 10차시 + QI 6차시), ② 두 트랙의 표준 교육설계 문서 2건, ③ 교수자용 ToT 과정 설계(과정계획안 5장), ④ 대학 간 현황 공유·확산 체계로 확정하였다.

2. 주요 개념 및 용어

본 과제에서 사용한 핵심 용어의 정의와 출처는 다음과 같다. 정의는 사업팀이 임의로 만든 것이 아니라, 국내 정책연구가 확정된 번역·정의와 원 문헌의 정의를 따른다.

[표 II-1] 주요 개념 및 용어 정의

용어	정의	출처
의료시스템과학(Health Systems Science, HSS)	의료시스템 안에서 환자와 인구집단을 위한 의료 제공의 질, 환자 및 사회의 경험, 건강 결과, 비용을 개선하는 데 필요한 원칙과 방법, 실천을 다루는 분야. 기초의학·임상의학에 이은 의학교육의 '제3의 기둥'으로 규정된다.	AMA(2017) 정의; Skochelak SE 외 편, Health Systems Science, 2nd ed., Elsevier, 2021; 이종태 외(2021) KAMC 정책연구의 국문 정의·번역 채택
시스템 사고(Systems Thinking)	부분이 아닌 '전체'를 인식하고, 상호의존성의 복잡한 거미줄과 다방향 인과관계를 인식하는 능력. HSS 개념 틀에서 핵심 영역과 기반 역량 영역을 아우르는 연결 영역(linking domain)에 해당한다.	이종태 외(2021) 개념 틀 <표 2-4>; 김세진 외, 「의료시스템과학에서의 시스템사고 교육을 위한 교수설계」, 『의학교육논단』 2023;25(3):212-228
건강의 사회적 결정요인(Social Determinants of Health, SDOH)	HSS 핵심 영역 중 '인구, 공중, 사회적 건강 결정요인' 영역. 개인이 아닌 전체 인구집단에 영향을 미치는 사회적 결정요인의 전 범위와, 의료 격차 해소를 위한 인구집단 건강 개선 전략을 포함한다.	이종태 외(2021) 개념 틀 <표 2-2> 핵심 영역 5; 본 과제 SDOH 트랙 과정명의 근거
질 향상(Quality Improvement, QI)	HSS 핵심 영역 중 '의료시스템 개선' 영역. 의료시스템 구성 요소의 성과를 개선하기 위해 정책·의료 제공·기타 시스템 기능의 변화를 확인·분석·실행하는 과정 일체를 포함하며, 격차의 계량과 감소, 측정, 데이터 분석, 중재, 학술활동을 포괄한다.	이종태 외(2021) 개념 틀 <표 2-2> 핵심 영역 7; 본 과제 QI 트랙 과정명 「환자안전을 위한 질향상」의 근거
SQUIRE 2.0	의료 질 향상 활동의 보고 표준(Standards for QQuality Improvement Reporting Excellence, 2015년 개정판). 개선 활동의 계획·실행·평가에서 형식·비형식 이론, 활동이 이루어진 맥락, 중재에 대한 연구라는 세 요소를 강조한다.	Ogrinc G, Davies L, Goodman D, Batalden P, Davidoff F, Stevens D. BMJ Qual Saf. 2016;25(12):986-992. 「HSS QI팀 과정 계획안」에서 QI 실습·평가의 표준 프레임으로 채택
교수자 양성 과정(Training of Trainers, ToT)	콘텐츠를 학생에게 직접 전달하기 위한 과정이 아니라, 그 콘텐츠를 자기 대학에서 가르칠 교수자를 길러내기 위한 별도 과정. 본 과제에서는 학생용 아키텍처와 분리하여 교수자 전용 블록을 신규 설계하였다.	2025.10.24 QI 소위원회 1차 결정; 「HSS QI팀 과정계획안」 5장
포괄 개념	HSS를 기존 교과와 경쟁하는 신설 과목이 아니라, 예방의학·의료윤리·인문사회의학 등 이미 존재하는 교육 내용을 하나의 관점으로 묶어 세우는 상위 개념으로 규정하는 방식. 사업 초기 개념 합의의 기준점이 되었다.	2025.7.24 킥오프 회의록 Ⅲ부 "HSS를 포괄 개념으로 정의, 기존 교과와 통합적 접근 제안"

용어	정의	출처
공유대학(K-MedU)	개별 대학이 단독 개발하기 어려운 교육 콘텐츠를 KAMC 차원에서 공동 개발·탐재하여 전국 의과대학이 학점교류·강의공유 형태로 활용하도록 하는 사업 내 공유 체계. 강좌단위·모듈단위 표준 개발계획서 양식을 운영한다.	공유대학팀(부산의대 임선주·최효선 교수) 배포 「강의개발계획서_K-MedU-20251201」 강좌단위·모듈단위 2종; 2025.12.2 팀장회의

3. 이론적 근거 및 선행연구

가. AMA HSS Consortium 프레임워크 — 무엇을 가르칠 것인가

미국의사협회(AMA)는 2013년 「의학교육 변화 가속화 이니셔티브(Accelerating Change in Medical Education)」를 출범시켜 11개 의과대학에 각 연간 100만 달러를 지원하는 시범사업을 시작하였고, 컨소시엄은 2019년까지 37개 의과대학으로 확대되었다. 이 컨소시엄이 정리한 HSS 프레임워크는 Gonzalo 외(2017)에서 학술적으로 정식화되었고, 교재 Health Systems Science(2판, 2021)로 집성되었다.

이 프레임워크는 핵심 영역 7개(환자·가족과 지역사회 / 의료 구조와 과정 / 의료 정책과 경제 / 의료정보과학과 기술의 활용 / 인구·공중·사회적 건강 결정요인 / 가치 기반 의료 / 의료시스템 개선), 기반 역량 영역 4개(변화관리 / 윤리와 법 / 리더십 / 팀워크), 연결 영역 1개(시스템 사고)로 구성된다. 이종태 외(2021)는 이 세 영역 구조와 하위 영역을 검토한 결과 한국적 맥락에서도 그대로 유지하기로 결정하고, 하위 영역의 개념적 정의와 예시 교육 내용만 한국 상황에 맞게 수정하였다.

나. Hoy & Miskel(2013) 개방 사회체제 모형 — HSS 도입은 교육과정 문제가 아니라 조직 문제다

HSS 도입이 왜 개념 정립과 콘텐츠 제작만으로 완결되지 않는지를 설명하기 위해, 본 과제는 Hoy와 Miskel의 개방 사회체제(open social system) 모형을 분석 틀로 참조하였다.

이 모형은 학교를 환경에 개방된 사회체제로 보고, 투입(inputs) → 전환 과정(transformation process) → 산출(outputs) → 환류(feedback)의 순환으로 조직 행동을 설명한다. 핵심은 전환 과정이 단일 요소가 아니라 네 개의 하위 체제로 구성된다는 점이다. 즉 ① 구조 체제(관료적 기대), ② 개인 체제(인지와 동기), ③ 문화 체제(공유된 지향), ④ 정치 체제(권력 관계)가 교수·학습이라는 기술적 핵심을 둘러싸고 상호작용한다. 그리고 이 모형이 제시하는 결론은 조직 효과성이 하위 체제 간 정합성(congruence)의 정도에 달려 있다는 것이다.

이 틀을 HSS 도입에 적용하면 다음과 같이 정리된다.

하위 체제	HSS 도입에서의 의미	구조만 정비할 경우의 한계
구조	교육과정 편성과 콘텐츠·문서 표준 등 제도적 기대	콘텐츠와 문서만 공급하면 플랫폼에 적재된 채 실제 수업으로 이어지지 않음

개인	교수자의 HSS 이해도, 교육 역량과 동기	임상 경력이 HSS 교육 역량을 자동으로 보장하지 않음
문화	HSS를 "진짜 의학"으로 인정하는가에 관한 공유 지향	학생·교수가 시험·수련과 무관한 내용으로 인식하여 이탈
정치	교육과정 시수 배분을 둘러싼 권력 관계, 학장의 의지	기존 교과목의 시수 방어에 밀려 실행 단계에서 축소

2021년 정책연구가 정착 과제로 도출한 세 범주 — ① 정의 및 구성 요소의 명료화, ② 교육과정 체계와 편성, ③ 교수개발 및 학습자 사전 준비 — 는 각각 문화·구조·개인 체제에 대응한다. 정치 체제에 관한 지적 역시 명시적으로 나타나 있다. "별도 교과목 개설은 현실적으로 어렵다", "임상 교수의 적극적 협조가 필요하다", "평가인증 기준에 반영하는 방안을 고려해 볼 수 있다"는 응답이 그것이다.

본 과제가 콘텐츠 개발(구조)에 더하여 교수자용 ToT 과정 설계(개인), 대학별 HSS 추진 현황의 정기적 상호 공유(문화), HSS 조직의 상설화를 협회 이사장에게 건의하는 방침(정치, 2026.2.24 팀장회의)을 병행한 것은 이 모형이 제시하는 정합성 요건에 따른 것이다. 2026년 7월 8일 HSS포럼에서 최용준 팀장이 학장·원장을 "그 대학의 최고교육책임자(Chief Education Officer)"로 재규정하고 서로 다른 전공의 교육자가 만날 기회를 만드는 주체로 지목한 것도 정치 체제에 대한 개입에 해당한다.

다. Gonzalo 외(2018) — HSS 통합에 대한 우려 2범주 8항목

Gonzalo 외(2018)는 2013년부터 2016년까지 교육자·임상의·기초과학자·의료시스템 리더·학술지 심사자와의 회의 및 대화를 통해 HSS를 학부의학교육에 통합할 때 광범위하게 제기되는 우려를 수집하고, 이를 두 범주 여덟 항목으로 정리한 뒤 각각에 대한 대응 전략을 제시하였다.

[표 II-2] HSS 통합에 대한 우려 2범주 8항목 (Gonzalo 외, 2018)과 본 과제의 대응

범주	우려 항목
(1) HSS 학습의 적절성과 중요성	① 변화의 시급성이 충분하지 않다
	② HSS는 너무 복잡하여 고학년에서 다루어야 한다
	③ 저학년 학생은 기여할 수 없고, 그 역할은 이미 존재한다
	④ 학문으로서 아직 미성숙하다
(2) HSS 교육의 실행 가능성과 실무	⑤ 교육과정 시간이 부족하다
	⑥ 전문성을 갖춘 교수자가 부족하다
	⑦ 인증기관·면허시험의 지원이 없다
	⑧ 의료시스템이 학교와 협력할 준비가 되어 있지 않다

라. 국내 선행연구

[표 II-3] 국내 주요 선행연구

문헌	유형	주요 내용	본 과제에 대한 함의
이종태 외(2021), 「의료와 사회의 통합적 이해와 실천을 위한 보건의료시스템과학 교육체계 구축 사업」, KAMC·국민건강보험공단	정책연구보고서	한국형 HSS 개념 틀 확정(핵심 7 + 기반 4 + 연결 1), 40개 교 대상 현황·요구 조사(23개교 응답), 미국 11개 시범대학 사례 분석, 개편 전략과 선도사업 모형 제시	개념 틀과 용어를 확정하여 본 과제가 개념 논쟁을 반복하지 않고 콘텐츠 개발로 직행할 수 있게 함
이종태 외(2023), 「의료시스템과학 교육 확산을 위한 교수개발 사업」, KAMC·국민건강보험공단	정책연구보고서	7개 핵심영역·연결영역별 성과·학습목표·교수설계 개발, 교재 번역, KAMC 공유 플랫폼 구축, 교수개발 프로그램 설계	교수개발이 확산의 선결 조건임을 선행 규정. 본 과제 ToT 설계의 직접적 선행
채유미·이영미·심선희(2023), 『의학교육논단』 25(3):198-211	종설(현황조사 기반)	국내 교육현황·요구도 + 미국 14개 의과대학 사례 분석. 전면 개편과 부분 개편 두 수준의 전략 제시, 실행 가능성 측면에서 부분 개편의 이점 강조	본 과제가 '전면 개편 요구'가 아니라 '기존 교과에 삽입 가능한 모듈' 형태를 택한 근거
김세진·이상미·이단비·윤보영(2023), 『의학교육논단』 25(3):212-228	교수설계 연구	연결 영역인 시스템 사고 교육을 위한 교수설계	시스템 사고를 독립 콘텐츠가 아닌 설계 원리로 다루는 접근의 국내 선행
나상훈(2023), 『의학교육논단』 25(3):229-242	사례개발 연구	임상실습 단계에서의 HSS 교육 사례 개발·적용. 전면 개편이 어려운 경우 각 대학 실정에 맞는 부분 수정·도입 경로 제시	임상실습 접점 설계의 국내 선례
안신기(2023), 『의학교육논단』 25(3):189-191	논설(특집 서문)	의대 정원 확대와 필수의료 논쟁의 맥락에서 의학교육의 대응을 문제화	본 과제의 사회적 배경 진술의 근거
김택중(2022), 『의사학』 31(3):519-546	비판적 논고	HSS의 미국적·프래그머티즘적 기원을 분석하고, 시스템 강조가 오히려 환자/사람을 소외시킬 위험을 지적. "한국에서 현재 의료시스템과학이란 실체 없는 유령이나 다름없다", "미국의 의료시스템'과학' 전부를 이식해 올 필요는 없다"고 진술	무비판적 직수입에 대한 국내의 대표적 반론. 본 과제가 '한국형 HSS 개념 정립 델파이'를 별도 연구 트랙으로 공식화한 직접적 계기
공혜정(2023), 『의사학』 32(2):623-659	의사학 연구	1910년대~2010년대 미국 의료체계 개혁과 의학교육 개혁의 맥락에서 HSS 등장의 역사적 배경 규명	HSS를 특정 국가의 제도사적 산물로 상대화하는 근거

국내 문헌 지형의 특징은 명확하다. 개념·전략·비판은 충분히 축적되었으나, 여러 대학이 공동으로 사용할 수 있는 표준화된 교육 콘텐츠와 설계문서는 산출된 바 없다. 2021년 정책연구가 요구조사에서 확인한 "학습역량 달성을 위해서는 실제 학생이 참여하는 실습이나 활동이 연계되어야 하는데 상당 부분 강의 수준에 머물러 있다"는 지적은 5년이 지난 시점에도 유효하였다.

마. 국외 선행연구

[표 II-4] 국외 주요 선행연구

문헌	주요 내용	본 과제에 대한 함의
Gonzalo JD, Dekhtyar M, Starr SR 외. Acad Med. 2017;92(1):123-131	AMA 컨소시엄 교육과정 분석을 통한 HSS 교육과정 프레임워크의 식별과 정의	핵심·기반·연결 영역 3층 구조의 학술적 원전
Gonzalo JD, Caverzagie KJ, Hawkins RE, Lawson L, Wolpaw DR, Chang A. Acad Med. 2018;93(6):843-849	HSS 통합에 대한 우려 2범주 8항목과 대응 전략	본 과제 설계 결정의 점검 목록(표 II-2)
Skochelak SE, Hammoud MM, Lomis KD 외 편. Health Systems Science, 2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2021	AMA 교육 컨소시엄 표준 교재 2판	본 과제 두 트랙의 공통 주교재. QI 트랙은 이 교재의 QI 장을 차시 구성의 기반으로 사용
Maben-Feaster R, Hammoud MM, Borkan J, DeWaters A, Gonzalo J, Starr SR 편. Health Systems Science Education: Development and Implementation. Elsevier(AMA MedEd Innovation Series)	커리큘럼 개발·실행의 실무 지침서	도입·운영 실무 설계의 참조 문헌
Richardson J, Gordon M, Pacis R, Wurster C, Hammoud MM. Acad Med. 2023;98(11 Suppl):S214-S215	미국 155개 의과대학 중 140개교 조사. 유의미한 통합 47%(심층 14% + 중간 33%), 사일로화 28%, 산발적 25%	HSS 발원지인 미국에서도 유의미한 통합은 47% 수준이다. 국내 도입 속도에 대한 현실적 기준선
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Health Systems Science Education: Proceedings of a Workshop. Washington, DC: National Academies Press; 2024	HSS 교육에 대한 학생·교수·교육과정·현장의 저항과 미국의 대응 정리	"먼저 가르칠 사람을 길렀다"는 대응 원칙. ToT 설계의 국제적 근거
Chang A, Pierluissi E, Cornes S 외. Acad Med. 2023;98(1):57-61	UCSF Clinical Microsystems Clerkship 사례	국외 사례 분석(4절)
Ziring D, Berg K, Mingioni N 외. Acad Med. 2020;95(9 Suppl):S444-S448	Thomas Jefferson JeffMD 교육과정 재설계 사례	국외 사례 분석(4절)
ACGME. Common Program Requirements(1999); Internal Medicine Milestones 2.0(2020)	1999년 '시스템기반진료(systems-based practice)'를 전공의 수련 역량으로 정립. 2.0 마일스톤은 환자안전·질향상, 시스템 내비게이션, 의료시스템 속 의사 역할의 3개 축을 5단계로 기술	HSS가 UME에 국한된 신조어가 아니라 GME 역량 체계와 연속선상에 있음을 보여줌. 학습성과 위계 설정의 참조

바. 선행연구의 한계와 본 과제의 차별성

선행연구의 한계는 세 가지로 요약된다.

첫째, 산출물의 층위가 다르다. 국내 선행연구는 개념 틀(2021), 교수설계 지침과 플랫폼(2023), 전략 제언(채유미 외, 2023), 개별 대학 사례(나상훈, 2023)를 산출하였으나, 여러 대학이 자기 대학 강의실에 그대로 투입할 수 있는 완성된 강의 콘텐츠와 표준 설계문서 세트는 산출한 바 없다. 2025년 10월 수정계획서 분석에서 확인된 '주차별 콘텐츠 설계 공백'은 이 한계의 현장 증거다.

둘째, 교수자 문제를 지적하되 해결 수단을 남기지 않았다. 2021-2023 정책연구, Gonzalo 외(2018), NASEM(2024)이 공통으로 교수개발을 선결 과제로 지목하였으나, 국내에는 교수자 전용 과정의 구체적 시간 배분과 블록 구성을 확정한 설계안이 부재하였다.

셋째, 한국적 재맥락화가 선언에 머물렀다. 이종태 외(2021)는 "HSS에 상응하는 우리말 용어에 대한 논의는 추후 과제로 남겨둔다"고 명시하였고, 김택중(2022)은 개념의 실체 부재를 정면으로 비판하였다. 그럼에도 한국 의학교육 맥락에서 HSS를 어떻게 재구성할 것인지에 대한 전문가 합의 절차는 착수되지 않았다.

본 과제의 차별성은 이 세 한계에 각각 대응한다.

선행연구의 한계	본 과제의 차별적 접근	1차년도 확인 결과
강의실 투입 가능한 공유 콘텐츠 부재	공유대학(K-MedU) 표준양식을 준수한 25~35분 단위 영상 콘텐츠 16개 (SDOH 10 + QI 6)와 표준 설계문서 2건(트랙별 통합문서 1건) 개발	콘텐츠 16개 구성 확정(설계·강사 배치 완료, 촬영 진행), 설계문서 2건 제출 완료(2026.4.21)
교수자 개발 수단 부재	학생용 아키텍처와 분리한 교수자용 ToT 과정 설계안(권장 6시간, 블록 A·A'·B·C·D·E·F 중 교수자 전용 신규개발 A'·E·F 3시간) 확정	설계안 1건 확정(「HSS QI팀 과정계획안」 5장)
한국적 재맥락화 절차 부재	'한국형 HSS 개념 정립 델파이'를 교육과정 개발과 병행하는 별도 연구 트랙으로 공식화	2026.4.22 5차 전체회의에서 별도 트랙으로 확정, 연구진 확정(김강철 1저자)

4. 국내외 사례

국내 사례는 2026년 4월 22일 5차 전체회의 「각 대학 HSS 교육 추진 상황 공유」에서 각 대학 참여 교수가 직접 보고한 내용을, 국외 사례는 2026년 7월 8일 HSS포럼 발제와 원 문헌을 근거로 정리하였다.

[표 II-5] 국내외 HSS 교육 운영 현황

구분	기관	주요 운영 내용
국내	한림의대	2023년 「의료의 사회적 맥락(Social Context in Medicine)」을 전신으로 하여 2024년부터 「의료시스템과학」 과목을 자체 개설. 1주일 단위 집중 운영. 예방의학·사회의학 2인, 임상교수 복수, 의학교육학 2인이 강의·토의에 공동 참여
국내	건국의대	2026년 「지역사회의학」 신설(의전원→의대 전환에 따른 부활). 대상 예과 1학년·본과 1학년, 주제는 건강의 사회적 결정요인(SDOH). 5월 첫 강의와 함께 학생 액티비티·실습 운영. 임상 수업·임상실습으로의 HSS 반영을 개인 목표로 제시
국내	성균관대의대	나선형식 교육과정 내 교육내용으로 운영. 「지역사회진료현장실습」, 「의학입문」 교과목에서 HSS 내용을 주요하게 다루고 있으며, 사회의학교실 및 의학교육학교실에서 교육과정 검토 진행
국외	Penn State College of Medicine	Systems Navigation Curriculum (SyNC). 강의실 수업과 환자 내비게이터 활동을 병행. 학생이 환자의 진료 여정을 따라가며 의료팀·비용·보험·환자안전·질향상·지역사회 자원이 진료와 어떻게 연결되는지 경험
국외	UCSF	Clinical Microsystems Clerkship (CMC). 1~2학년부터 실제 진료 현장에 배치. 여러 학생이 교수와 함께 진료과정·업무흐름을 관찰하고 진료지연·정보누락·환자경험 저하 등 시스템 격차를 확인. 학생이 배우는 동시에 현장의 질·안전 개선에 기여
국외	Thomas Jefferson Univ.(Sidney Kimmel Medical College)	JeffMD Curriculum. 기존 2+2 교육과정을 3단계 구조로 재설계하고 기초의학·임상의학·HSS를 4년 전체에 통합. 강의를 40% 이상 축소하고 사례바탕학습·팀바탕학습 확대. 교육과정·학생평가·임상실습·교수개발을 함께 변경

국외 세 사례의 공통점은 ① 여러 학년에 걸친 종단적 배치, ② 강의실 지식과 진료·현장 경험의 연결, ③ 학생을 의료팀·조직·제도·지역사회 안에서 진료에 참여시키는 구조, ④ 교육과정·임상실습·학생평가·환류의 동시 설계로 요약된다.

그러나 국내 학제는 이 조건을 그대로 충족할 수 없다. 미국은 조기 임상노출을 통해 연결고리를 만들지만, 국내에서 학생이 환자를 만나는 시점은 통상 본과 3~4학년이며 그 이전의 임상의학 교육은 '환자 없는' 강의실 수업이 중심이다. 이 학제적 차이가 국내 다수 대학이 미국의 경험을 그대로 적용할 수 없는 이유다. 2026년 7월 8일 HSS포럼은 이에 대한 국내적 대안으로 임상실습 전 교육에서 던진 질문이 임상실습에서 다시 살아나게 하는 설계를 제시하였다. 예컨대 당뇨병을 배울 때 "왜 관리가 안 되는가"를 함께 질문하고, 의료비·환자의 생활·가족 돌봄·의료접근성·지역사회 자원을 교육적 질문의 대상으로 삼는 방식이다.

5. 시사점 및 설계 방향

앞의 배경·이론·사례 검토에서 도출된 시사점과, 그것이 본 과제 1차년도 설계에 실제로 반영된 내용은 다음과 같다.

[표 II-6] 시사점과 설계 반영 내용

시사점	근거	설계 반영 내용
① HSS는 신설 과목이 아니라 좋은 진료를 위한 '렌즈'다. 기존 교과와 경쟁하는 순간 시수 배분의 정치에 밀린다	킵오프 회의록의 '포괄 개념' 규정 / 채유미 외(2023)의 부분 개편 전략 / Gonzalo 외(2018) 우려 ⑤ / 2026.7.8 HSS 포럼 "HSS는 임상 바깥에 있는 어떤 것이 아니라 좋은 진료를 위한 렌즈"	콘텐츠를 25~35분 단위 온라인 차시로 모듈화하여 기존 교과에 삽입 가능한 최소 단위로 제작. 두 트랙 설계문서에 KAMC 졸업성과(KGO) 매핑을 명시(SDOH: KGO 1·2·5 / QI: KGO 1·3). 성균관·의대·부산·의대·동아·의대·건양·의대가 각각 신규 교과, 2학점 선택과목, 비교과, 기존 교육과정 안착 등 서로 다른 경로로 활용할 수 있도록 단위를 분해
② 국내 공백은 '가치 기반 의료·의료시스템 개선·시스템 사고'와 경험 학습이다. 이미 잘 가르치는 영역을 다시 만들 이유가 없다	채유미 외(2023): 의료시스템 개선 8~13개교, 시스템 사고 5~7개교(21.7~30.4%) / 2021 정책연구 요구조사 "상당 부분 강의 수준에 머물러 있다"	도메인을 SDOH(핵심영역 5)와 QI(핵심영역 7) 두 개로 압축 확정 (2025.9.12 팀장회의, 시스템 사고 제외). QI 트랙에 SQUIRE 2.0 채택 + Flipped Learning·TBL + Case Based Learning 2차시 + 차시별 형성평가 퀴즈 2문항을 설계에 포함하여 강의 일변도를 탈피
③ 콘텐츠보다 교수자 확보가 선결 과제다. 오랜 임상 경험과 교육 역량이 HSS 교육 역량을 자동으로 보장하지 않는다	NASEM(2024) "먼저 가르칠 사람, 교육자부터 길렀다" / Gonzalo 외(2018) 우려 ⑥ / 2023 KAMC 교수개발 정책연구 / 2026.7.8 HSS포럼	교수자용 ToT 과정 설계안(권장 6시간)을 학생용 아키텍처(이론 4h + 실습 4h)와 분리하여 별도 확정. 교수자 전용 신규개발 블록 A·E·F(3시간)를 구분 설계. 교육학(팀장)·예방의학·응급의학·내과 전공을 고려하여 두 팀에 연구진을 배치(2025-09-12 잠정안, 2025-10-01 확정)
④ 개별 대학 단위 개발로는 도달할 수 없는 임계점이 있다. 미국조차 통합은 절반 수준이며, 국내는 계획은 있으나 콘텐츠가 없다	Richardson 외(2023): 140개교 중 유의미한 통합 47%(심층 14%) / 2025.10.1 3차 회의 수정계획서 분석: HSS 명시 9개교, 주차별 콘텐츠 설계 공백	개발 단위를 개별 대학이 아닌 KAMC 중앙 개발 + 공유대학(K-MedU) 탑재로 설정. 공유대학팀 배포 표준양식(강좌단위/모듈단위 2종)을 수정 요청 없이 그대로 준수하여 SDOH=강좌단위, QI=모듈단위로 분화 적용 (2026.2.24 팀장회의 방침). 대학별 HSS 추진 현황을 전체회의 정규 안건으로 두어 14개교 참여 상태를 유지
⑤ 미국의 개념을 그대로 옮겨오기보다, 한국 상황에 맞게 HSS 개념을 이해하고 적용하는 과정이 필요하다. 이를 위해 개념 정립 연구와 콘텐츠 개발을 병행한다	김택중(2022) "실체 없는 유령", "미국의 의료시스템'과학' 전부를 이식해 올 필요는 없다" / 이종태 외(2021) "우리말 용어 논의는 추후 과제" / 2026.4.22 "HSS 개념 정립이 선행되어야 한다"는 회의 발언	개념 정립을 선행 조건이 아닌 병행 트랙으로 배치. 「한국형 HSS 개념 정립 델파이」(김강철 1저자, 예방의학·의료인문학·의학교육·임상 전문가 대상, 2~3라운드)를 별도 연구 트랙으로 공식화(2026.4.22). 콘텐츠 측면에서도 SDOH 모듈 2를 「건강의 구조적 결정요인과 사회적 결정요인 — 한국의 불평등 현황과 메커니즘」으로 구성하여 한국 데이터를 전면 배치

이 다섯 가지 시사점을 관통하는 설계 원칙은 하나로 압축된다. 본 과제는 HSS를 국내 의학교육에 새로 도입하는 사업이 아니라, 여러 과정 또는 교과목에 분산된 교육 내용을 하나의 관점으로 묶을 수 있도록 각 대학에 표준 콘텐츠와 설계 도구를 제공하는 사업이다. Hoy와 Miskel의 개방 사회체제 모형이 시사하듯, 구조(콘텐츠·설계문서)만 공급하고 개인(교수자)·문화(대학 간 인식)·정치(학장·협회 차원의 지지)를 방치하면 산출물은 플랫폼에 적재된 채 사용되지 않는다. 1차년

도가 콘텐츠 16개와 설계문서 2건에 더하여 ToT 설계안, 14개교 참여 네트워크, 성과 확산 행사 2회, 그리고 2개 연구 트랙을 함께 남긴 것은 이 정합성 요건을 의식한 결과다.

다만 1차년도 시점에서 검증되지 않은 것도 분명히 해 둔다. 콘텐츠의 공유대학 플랫폼 탑재가 2026년 8월 이후로 예정되어 있어, 사업 기간 내에 학생 대상 사전·사후 데이터를 수집하는 것은 불가능하다. 이에 따라 효과성 평가는 '성균관대 파일럿 → 다대학 확대'의 단계적 로드맵으로 재구성되었으며, 연구 트랙 ①은 전체 참여자 공동 과제로 유지하되 범위를 조정하여 점진적으로 추진하기로 하였다(2026.4.22). 본 과제가 1차년도에 입증한 것은 교육 효과가 아니라 공동 개발이 가능하다는 사실과 그 산출물의 실재이며, 효과에 관한 판단은 2차년도 이후의 과제다.

02 과제 목표 및 성과지표

본 과제(세부과제 2-6, 「의료시스템과학(Health Systems Science, HSS) 교육과정 개발 및 적용」)은 개별 대학의 교육과정 개선 사업이 아니라, 40개 의과대학이 공유할 수 있는 교육 성과물을 공동으로 제작하는 개발형 과제다. 2025년 7월 24일 킥오프 회의에서 "연구가 아닌 40개 의대 공유 성과물"이라는 프레임이 합의된 이후, 모든 목표와 성과지표는 '무엇이 만들어졌고, 어느 대학의 어느 교육과정에서 쓰이는가'를 기준으로 설정·관리되었다.

1. 목표

1.1 목표 체계

구분	내용
최종 목표	국내 의과대학이 공동으로 활용할 수 있는 의료시스템과학(HSS) 표준 교육과정과 온라인 강의 콘텐츠를 개발하여, 공유대학(K-MedU) 플랫폼에 탑재하고 개별 대학 교육과정(정규·비교과·자유선택)에 적용·확산한다. 아울러 한국 맥락에 맞는 HSS 개념과 교육모델을 정립하기 위한 후속 연구 기반을 구축한다.
1차년도 목표(2025.6.1~2026.8.31, 실질 2025.7.24 킥오프~)	① 도메인·조직 확정: 1차년도 개발 도메인을 확정하고 도메인별 개발팀 체계를 구축한다.② 콘텐츠 개발: 확정된 2개 도메인(SDOH·QI)의 온라인 강의 영상 콘텐츠를 개발한다.③ 설계 표준화·교수자 지원: 공유대학 표준양식에 따른 교육설계 문서를 산출하고, 도입 대학의 교수자를 지원할 ToT 과정을 설계한다.④ 확산·후속연구 기반: 참여 대학을 확대하여 대학별 HSS 추진 현황을 공유하고, 사업 성과를 대외에 발표하며, 후속 연구계획을 공식화한다.
과제 범위 — 포함	· SDOH 트랙: 5개 모듈 10차시 온라인 강의 콘텐츠(차시당 25~35분)· QI 트랙: 2개 모듈 6차시 온라인 강의 콘텐츠(차시당 25~35분, Flipped Learning+TBL 연계)· K-MedU 표준양식 기반 (통합)강의·모듈 개설신청서 및 계획서 2종 × 2트랙· QI 교수자용 ToT 과정 설계안(권장 6시간 구성)· QI 평가도구 및 서식(TBL 활용지 IRAT/GRAT, SQUIRE 2.0 체크리스트·루브릭, QI 프로젝트 RFP 양식) — 설계 단계까지 포함, 실물 완성은 2차년도· 대학별 HSS 추진 현황 공유 및 대외 성과 발표· 후속 연구 2트랙(효과성 평가·한국형 HSS 델파이) 계획 수립

1.2 세부목표와 성과지표의 연계

1차년도 세부목표	대응 KPI (KAMC 지표)
① 도메인·조직 확정	선행 조건 — KPI 1·2의 전제(개발 도메인과 팀 체계 확정)
② 콘텐츠 개발	KPI 1 SDOH 교육콘텐츠 개발 완료, KPI 2 QI 교육콘텐츠 개발 완료, KPI 3 HSS 동영상 콘텐츠 제작 완료
③ 설계 표준화·교수자 지원	KPI 4 HSS 동영상 공유대학 탑재(표준양식 개설신청 서류가 선행 절차)
④ 확산·후속연구 기반	KPI 5 교육과정 및 연구성과 확산 활동 수행

2. 성과지표

본 과제의 성과지표는 KAMC 「의학교육혁신사업 핵심성과지표(안)」(2025. 10. 12.)에 정의된 전략목표 G5 「의료시스템과학(Health Systems Science: HSS) 교육과정 개발 및 적용」의 KPI를 따른다. 동 문서에서 본 과제의 핵심성공요인(CSF)은 「교육과정의 시각화 및 학습자료 제작, 지속 가능한 환류체계 구축」이며, 관리 책임은 최용준·김강철로 지정되어 있다. 달성목표는 Y1~Y3을 「설계 및 제도화」, Y4~Y5를 「고도화」 단계로 구분한다.

연번	KPI명 (KAMC 지표)	연차
1	SDOH 교육콘텐츠(교안·평가 포함) 개발 완료	Y1
2	QI 교육콘텐츠(교안·루브릭 포함) 개발 완료	Y1
3	HSS 동영상 콘텐츠 제작 완료	Y1
4	HSS 동영상 공유대학 탑재 여부	Y1
5	교육과정 및 연구성과 확산 활동 수행	Y1
6	공유대학 탑재한 HSS 동영상 보완 및 확산 여부	Y2

1차년도(Y1) 지표는 5개이며, 나머지 1개는 2차년도(Y2) 지표다. 지표별 달성 현황과 판정은 Ⅶ장 1절에 제시한다.

03 추진 체계 및 방법

본 과제는 개별 대학의 연구 산출이 아니라 40개 의과대학이 공유할 수 있는 교육 성과물을 만드는 것을 목표로 하였다. 이 목표는 2025년 7월 24일 킥오프 회의에서 "연구가 아닌 40개 의대 공유 성과물"이라는 프레임으로 합의되었으며, 이후 추진 체계와 개발 방법의 설계 원칙이 되었다.

1. 추진 체계

추진 체계는 전체 TF, 팀장회의, 도메인 소위원회의 3층으로 구성하였다. 이 구조는 사전에 설계된 것이 아니라, 2025년 8월 29일 2차 회의에서 2팀 체제를 채택하고 9월 12일 팀장회의에서 도메인을 확정하는 과정을 거치며 형성되었다.

3층 구조의 기능 분담은 다음과 같다. 전체 TF(제1~5차 전체회의)는 사업의 프레임, 개발 도메인, 산출물의 범위를 합의하고 대학 간 현황을 공유하는 최상위 합의체이다. 도메인 선정(QI·SDOH 2개 확정, 시스템 사고 제외), 과정명·학점 단위·모듈 구조 확정, SDOH 차시 재확정과 같이 사업의 범위를 바꾸는 결정은 모두 전체 TF에서 이루어졌다. 팀장회의는 전체회의 사이의 간격을 메우는 실무 결단 단위로, 개발 목표량의 구체화(2025-12-02, 강의 콘텐츠 15개), K-MedU 양식 준수 결정, 촬영업체 변경과 트랙별 촬영 접근 분화(2026-02-24) 등 실행 조건에 관한 사항을 처리하였다. 도메인 소위원회는 각 트랙의 수업 설계 언어를 확정하는 단위이다. SDOH·QI 두 트랙 모두 개발 진행에 맞추어 수시로 운영하였으며, 논의 결과는 전체회의에서 공유·확정하였다. QI 트랙에서는 SQUIRE 2.0 채택, Flipped Learning+TBL 교수법 확정, 압축형 4시간/확장형 8시간 이중 트랙, 교수자용 ToT 별도 설계, 필수 산출물 3종 목록화, 강사진 배분을 정리하였고, 그 내용은 「과정계획안」과 검토의견서로 확정하였다.

1차년도 공식 회의는 총 9회다. 도메인 소위원회는 트랙별로 수시 운영하였으므로 이 집계에 포함하지 않았고, 포럼·세미나는 확산 실적으로 분류하였다.

조직	구성	주요 기능	개최 주기·횟수
전체 TF (제1~5차 전체회의)	팀장 최용준(한림대), 간사 김강철(서울대), SDOH·QI 팀장 및 전 참여위원	사업 프레임·개념 합의, 개발 도메인 선정, 과업 범위·산출물 범위 확정, 대학별 HSS 추진 현황 공유, 연구 트랙 공식화	비정기(2~4개월 간격), 5회
팀장회의	팀장, 간사, SDOH 팀장 김세진(동아대), QI 팀장 지영아(성균관대)	전체회의 사이의 실무 결단 — 개발 목표량 구체화, 표준양식 적용 방침, 제작 방식·업체 결정, 신규 위원 합류 확인, 대외 발표 방향 설정	비정기, 3회
도메인 소위원회 (SDOH·QI)	SDOH 팀장 김세진, QI 팀장 지영아 및 트랙별 개발참여 위원	도메인별 수업 설계 언어 확정 — 과정명, 평가 프레임 (SQUIRE 2.0), 교수법, 운영 옵션, ToT 설계, 산출물 목록, 강사 배분	트랙별 수시
포럼·세미나 (대외)	사업팀 및 외부 발제자	사업 성과의 대외 공유, 개념적 재정박(한국형 재맥락화)	2회

사업팀 회의록 명단 기준(워크숍은 참석자 명단 기준) 누적 참여는 연인원 72명이다. 도메인 소위원회는 트랙별로 수시 운영하였으므로 회의 수에 계상하지 않았고, KAMC 학술대회 중간발표와 대전충청권 HSS포럼은 대외 발표 행사이므로 확산 실적으로 분류하였다.

SDOH 트랙은 정례 소위원회 대신 팀장(김세진) 주도의 개발 담당 체계로 수시 논의하고 전체회의에 보고하는 방식으로 운영되었다. 이는 SDOH 트랙이 외부 전문 강사 5인(정최경희(이화여대)·윤태호(부산대)·Howard Waitzkin(UNM)·장숙량(중앙대 간호대)·추혜인·어라(살림)의 강의를 배치하는 구조여서, 내부 설계 논의보다 강사 컨택과 모듈 배치가 핵심 과업이었던 데 따른 것이다. 2026-02-24 팀장회의에서 QI는 내부 연구진 촬영으로 결정되었고, SDOH는 외부 강사 섭외를 전제로 진행하기로 하였다.

한편 2026년 2월 24일 팀장회의에서는 본 TF를 사업 종료 이후에도 유지되는 상설 조직으로 전환하는 방안을 KAMC 이사장에게 건의하기로 하였다. 이는 1차년도에 형성된 도메인 팀 구조가 콘텐츠 제작 이후의 운영·개정 단계에서도 필요하다는 판단에 따른 것이다.

2. 참여 대학

1차년도 참여 대학은 연구진 소속 기준 14개교이다. 참여 형태는 (가) 사업 총괄·트랙 팀장 소속교, (나) 개발진 소속교, (다) 연구위원 소속교로 구분된다.

연번	대학	참여 형태	담당자
1	한림대학교 의과대학	사업 총괄(팀장 소속교), QI 개발진 소속. 2024년부터 '의료시스템과학' 과목 자체 개설·1주 단위 운영	최용준(의료관리학, 팀장), 정승민(사회의학, QI 개발·강의)
2	서울대학교 의과대학	간사 소속교, QI 개발진 소속교, 키포프·제4차 전체회의 개최교. 6년제 위원회에 HSS 포함 결정	김강철(의학교육학, 간사), 이선영(휴먼시스템의학, QI 자문), 나상훈(순환기내과학, QI 강의), 이승희(의학교육학)
3	동아대학교 의과대학	SDOH 트랙 팀장 소속교. 비교과 1개 개발 의향(예방의학+의학교육학+의료인문학 공동)	김세진(의학교육학/교육공학, SDOH 팀장)
4	성균관대학교 의과대학	QI 트랙 팀장 소속교, 델파이 연구 PI 및 IRB 주관기관. 나선형식 교육과정 내 교육내용으로 운영, 사회의학교실·의학교육학교실 합동 교육과정 검토 진행	지영아(의학교육학, QI 팀장)
5	인제대학교 의과대학	SDOH 개발진 소속, 외부 강사 컨택 창구	김새롬(예방의학)
6	경희대학교 의과대학	SDOH 개발진 소속교	임윤주(호흡기내과학)
7	충남대학교 의과대학	신규 연구위원 소속교(2025-12-02 합류). 의료인문학교실 2026년 3월 개설, 공유 프로그램 활용 예정	양지현(의료인문학, 김정란 교수 후임)
8	건국대학교 의과대학	2026년 '지역사회의학' 신설(주제=SDOH), 예과 1학년·본과 1학년 대상, 5월 첫 강의 및 실습 운영	이지혜(예방의학)
9	전남대학교 의과대학	SDOH 개발진 소속교 — 임상 사례 관점 검토	조용수(응급의학)
10	울산대학교 의과대학	신규 연구위원 소속교(2025-12-02 합류)	강동윤(예방의학)
11	경북대학교 의과대학	연구진 소속교. 연구진 소속교	강지연(의료인문학/의학교육학)

연번	대학	참여 형태	담당자
12	아주대학교 의과대학	신규 연구위원 소속교	홍세리(예방의학)
13	부산대학교 의과대학	연구위원 소속교 겸 공유대학팀 소속교(K-MedU 표준양식 배포·품질 심사). 의학과 2학점 선택과목 활용 논의, 워크시트·활동자료 동반 개발 요청	윤소정(의학교육학), 임선주·최효선(공유대학팀), 윤태호(SDOH 모듈 2 강사)

14개교는 연구진 18인의 소속 대학을 기준으로 산정하였다. 기준 명단은 2025년 8월 29일 제2차 전체회의에서 확정된 「KAMC 과제별 일정 — 2-6.HSS」의 16인에, 이후 협력으로 참여한 윤소정(부산대)·천경희(건양대) 2인을 더한 것으로, 2026년 7월 현재 사업팀 상시 소통 채널 참여 인원과 일치한다.

이전 자료에 나타나는 '10개교'는 2026년 4월 22일 제5차 전체회의의 「각 대학 HSS 교육 추진 상황 공유」 표에 발언 기록이 있는 9개교(한림·인제·동아·충남·부산·서울·건국·성균관·건양)에 경희대학교를 더한 값으로, 산정 기준이 다르다. 현황 공유 9개교는 모두 위 14개교에 포함되며, 연구진 소속이면서 동 표에 발언 기록이 없는 대학은 경희·전남·울산·경북·아주 5개교이다.

참여 형태에서 확인되는 특징은 두 가지이다. 첫째, 교육혁신 지원사업에 직접 참여하는 대학(부산·건양)과 그렇지 않은 대학(한림·서울·동아·인제 등)이 혼재한다. 이는 본 과제가 개별 대학 사업의 하위 과업이 아니라 KAMC 차원의 공동 개발 과제로 설계되었기 때문이다. 둘째, 다수 대학이 "자체 개발보다 공유 콘텐츠 활용"을 명시하였다(동아·충남·부산·건양). 2025-10-01 3차 회의에서 26개교 수정사업계획서 분석 결과 콘텐츠 수준(주차별 주제·핵심개념·평가)의 구체적 제안이 부족한 것으로 공유되었다.

3. 개발 방법

개발 방법은 (1) 근거 확보, (2) 현장 수요 확인, (3) 합의 형성, (4) 검토·표준화의 순으로 배치하였다. 1차년도에는 문헌고찰·수정계획서 분석·합의회의·전문가 검토를 실행하였고, 델파이와 시범운영은 2차년도 과업으로 이월하였다.

방법	대상	시기	활용
문헌고찰	Skochelak et al. (2021) Health Systems Science 2nd ed. 및 이종태 외(2025) 번역서, Maben-Feaster et al. (2022) Health Systems Science Education (126pp), SQUIRE 2.0	2025.7~2026.6	HSS의 개념 정의(제1차 전체회의), 두 트랙 교재 지정, QI 평가·보고 프레임 채택
수정사업계획서 분석	교육혁신 지원사업 참여 26개교(37개교 중) 수정사업계획서	2025.10 (제3차 전체회의 공유)	HSS 명시 9개교 확인, "주차별 콘텐츠 설계 공백" 진단 → 공유 콘텐츠 개발의 필요 근거 및 개발 우선순위 설정
합의회의	전체회의 5회, 팀장회의 3회, 워크숍 1회 (총 9회)	2025.7~2026.8	도메인 확정(QI·SDOH), 과정명·학점 단위·모듈 구조 확정, 콘텐츠 15개 목표 설정, 차시 범위 재확정(SDOH 9차시·QI 6차시 → 촬영 단계 조정으로 16차시), 연구 3건 계획 확정
전문가 검토	「HSS QI팀 과정계획안」 6개 항목(개요·목표·아키텍처·ToT·산출물·평가) 팀 내 회람	2025.11.10	검토의견서 회람 → 과정계획안(2025-12-12 제4차 전체회의 [첨부6.1]) 확정
대외 발표 검증	KAMC Annual Meeting 중간발표(2025.11.14~15), 제4회 교육부 성과공유세미나 대전충청권 HSS포럼(2026.7.8, 5개 발제)	2025.11, 2026.7	진행 상황의 정직한 공유, 한국형 재맥락화 언어 확보("새 과목이 아니라 좋은 진료를 위한 렌즈"), Cynefin·빙산 모델 등 개념틀 도입
델파이 (2차년도)	예방의학·의료인문학·의학교육·임상 전문가 패널	2027.1 예정	한국형 HSS 개념·범위 정립. PI 및 IRB 성균관대, 2~3라운드
시범운영 (2차년도)	공유대학 탑재 콘텐츠 수강생	2026.8 이후	성균관대 파일럿 → 다대학 확대의 단계적 로드맵. 효과성 평가 데이터 수집

개발 단위의 표준화. 개발 방법에서 가장 실질적인 표준화 조치는 공유대학 양식의 채택이다. 2025년 12월 2일 팀장회의에서 공유대학팀(부산의대 임선주·최효선 교수)이 배포한 K-MedU 강의개발계획서 양식 2종(강좌단위·모듈단위, 20251201 배포용3)을 수령하고 이를 준수하기로 결정하였다. 2026년 2월 24일 팀장회의에서는 "양식 수정 요청 없이 그대로 활용하고, 팀별 기존 설계안을 양식에 맞춰 변환"하는 방침을 확정하였다. 그 결과 SDOH는 강좌 단위, QI는 모듈 단위(다중 모듈 2개)로 분화 적용되어 2026년 4월 21일 두 트랙의 (통합)강의·모듈 개설신청서 및 계획서 2건이 제출되었다.

콘텐츠 규격. 온라인 영상 1차시는 25~35분으로 하고, 이를 콘텐츠 1개로 계수하였다. 이 규격에 따라 1차년도 목표 16개(SDOH 10차시 + QI 6차시)를 설정하였다. 공유교육 원칙의 동영상 길이 기준(30~35분, 15분 2 package 편성)은 이 범위 안에 들어오므로 규격 상충은 없다(2026-08-02 확인).

교수법 설계. 두 트랙의 교수법은 도메인 특성에 따라 분화하였다. SDOH는 100% 온라인 강의 중심으로, QI는 온·오프라인 혼합 방식으로 Flipped Learning과 TBL을 결합하고 차시별 퀴즈 2문항의 형성평가와 총괄평가(시험 1회·과제 1회)를 배치하였다. QI 트랙은 대학별 운영 여건 차이를 고려하여 압축형 4시간/확장형 8시간의 이중 트랙 운영 옵션을 두었으며, 교수자용 ToT 과정을 별도로 설계하였다.

산출 실적. 개발 계획 대비 산출은 아래와 같다. 성과지표 판정은 KAMC KPI 기준으로 Ⅲ장 2절·Ⅶ장 1절에 별도로 제시하였다.

산출 항목	계획	산출
영상 콘텐츠 차시	16개	16개 설계·강사 배치 확정, 촬영 진행 (SDOH 10 + QI 6)
개발 모듈	7모듈	7모듈 (SDOH 5 + QI 2)
교수자용 ToT 설계	1건	1건 (「HSS QI팀 과정계획안」 5장) — 영상화는 2차년도 이월
참여 대학	14개교	14개교
대외 발표	2회	2회

다만 산출의 성격을 정확히 기재할 필요가 있다. 콘텐츠 16개는 2026년 7월 현재 강사 확정 및 촬영 진행 단계로, 공유대학(K-MedU) 플랫폼 탑재는 2026년 8월 이후로 예정되어 있다. 교수자용 ToT 지표는 설계안 산출에 한정되며, ToT 영상 2강좌의 제작은 2026년 4월 22일 제5차 전체회의에서 "TOT 2개 → HSS 오리엔테이션 2개 변경"으로 확정되었다. 과정계획안이 구성을 '권장 6h'로, 하단 합계를 '총 7h(교수자용 3h)'로 표기한 것은 각각 권장 운영 시수와 전체 블록 합계를 가리키는 것으로, 상충하지 않는다.

4. 연구윤리

IRB. 1차년도 과업은 교육과정 설계·콘텐츠 개발과 사업 참여자 간 합의회의로 구성되어, 인간 대상 연구에 해당하는 자료 수집이 이루어지지 않았다. 따라서 1차년도에는 IRB 심의 대상 활동이 없다.

2차년도에는 심의가 필요하다. 연구 2트랙 중 ① 공유 교육과정 효과성 평가(김세진 제안)는 사전·사후 설문과 FGI를 결합한 혼합연구로 설계되어 학생 대상 자료 수집을 수반하며, ② 한국형 HSS 개념 정립 델파이(김강철 1저자)는 전문가 패널 대상 2~3라운드 조사를 포함한다. 델파이 연구의 IRB 주관기관은 성균관대학교이며, 자료 수집 개시 전 심의를 완료한다. 효과성 평가는 콘텐츠 탑재 시점이 2026년 8월 이후여서 사업 기간 내 학생 pre-post 데이터 수집이 불가능하므로, 범위를 '개발·운영 과정 기록' 중심으로 축소 조정하고 '성균관대 파일럿 → 다대학 확대'의 단계적 로드맵으로 재구성하였다. 각 트랙의 자료 수집 개시 전 해당 주관기관 IRB 승인을 받는 것을 원칙으로 한다. 건양의대가 주관하는 협력 연구인 시스템 사고 교육모델 DBR(천경희 제안)은 심의 주관도 건양의대에서 판단한다.

저작권. 개발 콘텐츠는 KAMC 공유대학(K-MedU) 플랫폼을 통해 40개 의과대학이 공동 활용하는 것을 전제로 하므로, 개별 강사가 아닌 사업 차원의 이용 권한 확보가 전제된다. 특히 SDOH 트랙은 5개 모듈 전량을 외부 전문 강사(정최경희(이화여대)·윤탤희(부산대)·Howard Waitzkin(UNM)·장숙량(중앙대 간호대)·추혜인·어라(살림)의 강의로 구성하여, 강사별 저작권 이용 동의서 확보가 콘텐츠 활용의 필수 조건이다. QI 트랙은 사업 참여 교수진이 내부 촬영하는 구조여서 상대적으로 권리 관계가 단순하나, 동일한 동의 절차를 적용한다.

교재 인용에 관해서는 두 트랙 모두 KAMC 번역서 『의료시스템과학: 의학교육 변화를 위한 이니셔티브』(이종태 외, 2025)와 원서(Skochelak et al., 2021, 2nd ed.)를 지정 교재로 명시하였으며, 강의 슬라이드에 포함되는 인용 자료는 출처를 표기한다.

5. 추진 일정

1차년도 추진은 설계 → 구조화 → 제작 → 정리·확산의 4단계로 진행하였다. 각 단계는 전체회의 또는 팀장회의의 확정 결정을 경계로 구분된다.

단계	기간	주요 활동	산출물
1단계: 설계	2025.7~9	kick-off(7.24, 서울의대 국제관 옥정홀) 11인 TF 구성, "40개 의대 공유 성과물" 프레임 및 HSS 개념 합의 / 제2차 전체회의(8.29) 2팀 체제 채택, 도메인 3후보 검토 / 팀장회의(9.12) 도메인 QI·SDOH 2개 최종 확정(시스템 사고 제외), 팀장 지영아·김세진 지정, KAMC 학술대회 발표 방향 설정	사업 프레임 합의, 2트랙 개발 체제, 팀장 배치
2단계: 구조화	2025.10~12	제3차 전체회의(10.1, ZOOM) 팀 배치 확정, 26개교 수정계획서 분석 공유("주차별 콘텐츠 설계 공백" 확인, HSS 명시 9개교) / QI 소위 1차(10.24) 과정명 확정, SQUIRE 2.0 채택, Flipped+TBL, 이중 트랙(4h/8h), ToT 별도 설계, 강사진 배분 / QI 소위 2차(11.10) 검토의견서 회람 / KAMC Annual Meeting 중간발표(11.14~15) / 팀장회의(12.2) 콘텐츠 15개 목표 구체화, K-MedU 양식 준수 결정, 신규 위원 합류 / 제4차 전체회의(12.12, 서울의대 국제관 105호) 과정명·학점 단위·모듈 구조 확정	「HSS QI팀 과정계획안」 및 검토의견서, 「HSS-SDOH 학습성과 및 목표 작업양식」(251110 수정), K-MedU 표준양식 2종 수령, KAMC 중간발표 자료
3단계: 제작	2026.1~6	팀장회의(2.24) 촬영업체 변경, SDOH=외부강사·QI=내부촬영 접근 분화, 상설 조직화 이사장 건의 방침 / 트랙별 설계문서 변환·제출(4.21 최종 제출) / 제5차 전체회의(4.22, ZOOM) SDOH 5모듈 9차시로 범위 확정, QI 6개 콘텐츠 확정, ToT 2개 →HSS 오리엔테이션 2개 변경, 연구 2트랙 계획 확정, 대학별 현황 공유 / 강사 확정 및 촬영 진행 / 번역서 1차 교열(6.29)	(통합)강의·모듈 개설신청서+계획서 2건(트랙별 1건), 연구계획 2트랙 계획안, 강의 영상 촬영 진행분
4단계: 정리·확산	2026.7~8	제4회 교육부 성과공유세미나 대전충청권 HSS포럼(7.8) 5개 발제 — 한국형 재맥락화 언어 확보 / 건양의대 Systems Thinking 콘텐츠 개발(7.31 완료 목표) / 콘텐츠 후반 제작 및 공유대학 탑재 준비 / 1차년도 최종보고서 작성	HSS포럼 발제자료 5건, 1차년도 최종보고서, 공유대학 탑재용 콘텐츠 패키지(탑재는 2026.8 이후)

둘째, 콘텐츠 탑재와 효과성 검증은 2차년도로 이월되었다. 촬영 완료 목표를 2026년 6월로 두었으나 2026년 7월 현재 강사 확정·촬영 진행 단계이며, 공유대학 플랫폼 탑재는 2026년 8월 이후이다. 이에 따라 학생 대상 pre-post 데이터 수집이 사업 기간 내에는 불가능하므로, 효과성 평가는 개발·운영 과정 기록 중심으로 범위를 조정하고 실행은 사업 종료 후로 이월하였다.

04 추진 경과 및 실적

1. 단계별 추진 경과

1차년도 추진은 ① 설계 → ② 구조화 → ③ 제작 → ④ 조정·정리의 네 국면으로 진행되었다. 각 국면은 직전 국면이 확정된 결정을 전제로 다음 단계의 작업 단위를 좁혀 가는 방식으로 이어졌다. 다만 제작 국면과 조정·정리 국면은 2026년 4~6월 구간에서 일부 병행되었다.

국면	기간	핵심 결정	다음 국면으로의 연결
① 설계	2025.7.24~9.12	사업 성격(공유 성과물), HSS 개념, 2팀 체제, 도메인 2개(QI·SDOH) 확정	무엇을 만들지 확정 → 개발 단위·구조 설계로 이행
② 구조화	2025.10.1~12.12	26개교 계획서 분석, 과정명·교수학습 전략·산출물 목록, K-MedU 표준양식 준수, 콘텐츠 15개 목표	설계 언어 확정 → 표준양식 변환·촬영 준비로 이행
③ 제작	2026.2.24~2026.6	촬영 접근 분화(SDOH 외부강사/QI 내부촬영), 설계문서 2건 제출, 차시 범위 재확정(2026-04-22 기준 9+6=15 → 촬영 단계 조정 후 10+6=16)	문서 산출 → 영상 제작 및 플랫폼 탑재 준비로 이행
④ 조정·정리	2026.4.22~8.31	과업 범위 재확정, ToT 산출물 범위 조정, 연구 3건 계획 확정, 대외 확산	1차년도 산출 확정 → 탑재·운영·연구 실행을 차년도로 이월

가. 설계(2025.7.24~9.12)

2025년 7월 24일 서울대학교 의과대학 국제관 옥정홀에서 11인 태스크포스로 킥오프 회의(제1차 전체회의)를 개최하였다. 이 회의에서 본 과제를 "연구가 아니라 40개 의과대학이 공유할 성과물을 만드는 사업"으로 규정하고, HSS를 개별 신설 과목이 아닌 여러 교육 내용을 포괄하는 개념으로 합의하였다.

2025년 8월 29일 2차 전체회의(제2차 전체회의)에서 2팀 체제와 도메인 3개 후보를 검토하였고, 9월 12일 팀장회의에서 도메인을 QI와 SDOH 2개로 최종 확정하고 시스템 사고는 개발 범위에서 제외하였다. 팀장은 QI 지영아(성균관의대), SDOH 김세진(동아의대)으로 배치하였다. 같은 회의에서 11월 KAMC Annual Meeting 중간발표를 "무리한 속도 대신 계획과 진행상황을 정직하게 공유"하는 방향으로 정하였다.

나. 구조화(2025.10.1~12.12)

2025년 10월 1일 3차 전체회의(제3차 전체회의, ZOOM)에서 2팀 배치를 확정하고, 교육혁신 지원사업 참여 의과대학의 수정사업계획서 26개교분 분석 결과를 공유하였다. 분석 결과 26개교 중 HSS를 명시한 곳은 9개교였고, 다수 대학이 HSS를 계획서에 언급하면서도 주차별 콘텐츠 설계에 대한 구체적 제안은 부족한 것으로 확인되었다.

10월 24일 QI 소위원회 1차에서 도메인별 수업 설계 언어를 확정하였다. 과정명 "환자안전을 위한 질향상", 평가·실습의 표준 프레임으로 SQUIRE 2.0 채택, 교수 학습 전략으로 Flipped Learning과 TBL, 운영은 압축형 4시간·확장형 8시간 이중 트랙, 교수자용 ToT의 별도 설계(권장 4시간 → 6시간 조정), 필수 산출물 3종 (TBL 활용지, SQUIRE 2.0 체크리스트·평가 루브릭, QI 프로젝트 RFP 양식)과 강사진 배분을 정리하였다. 11월 10일에는 「HSS QI팀 과정계획안 검토의견서」를 6개 항목(개요·목표·아키텍처·ToT·산출물·평가)별로 회람하여 의견을 취합하였고, 그 결과가 과정계획안으로 수렴되었다.

이 국면에서 설계 언어와 문서 양식이 고정되었고, 다음 국면은 기존 설계안을 표준양식으로 변환하여 촬영에 진입하는 문제로 이동하였다.

다. 제작(2026.2.24~2026.6)

2026년 2월 24일 팀장회의에서 촬영업체를 변경하고, 제작 접근을 SDOH는 외부 강사 촬영, QI는 내부 촬영으로 분화하였다. 양식에 대해서는 수정 요청 없이 그대로 활용하고 팀별 기존 설계안을 양식에 맞춰 변환한다는 방침을 확정하였으며, HSS 추진 조직의 상설화를 협회 이사장에 건의하는 방침도 함께 정하였다.

4월 21일 두 트랙의 표준 교육설계 문서 2건(트랙별 (통합)강의·모듈 개설신청서 + 강의·모듈 계획서)을 최종 제출하였다. 두 트랙 모두 1차 제출본을 거쳐 2026년 4월 21일 최종 제출하였다.

4월 22일 5차 전체회의(제5차 전체회의, ZOOM)에서 SDOH를 5개 모듈 9차시로 축소 개발하기로 하고, QI는 2026년 6월까지 6개 콘텐츠 개발을 완료하기로 확정하였다. 이로써 이 시점의 콘텐츠 구성은 15개(SDOH 9 + QI 6)로 확정되었고, 이후 촬영 단계에서 SDOH의 한 개 모듈을 2차시로 나누어 촬영하면서 최종 16차시(SDOH 10 + QI 6)가 되었으며, 두 트랙 모두 촬영 단계에 진입하였다. 2026년 7월 현재 강사 확정과 촬영이 진행 중이며, 공유대학(K-MedU) 플랫폼 탑재는 2026년 8월 이후로 예정되어 있다. 외국 강사(Howard Waitzkin)는 줌 원격 촬영으로 2차시 분량을 확보하였으며, QI 'HSS 오리엔테이션' 2개 차시의 전달 강사는 미확정 상태이다.

라. 조정·정리(2026.4.22~8.31)

제5차 전체회의를 기점으로 과업 범위와 후속 계획을 실행 가능한 형태로 재조정하였다. 첫째, QI 트랙의 ToT 영상 2강좌 제작을 HSS 오리엔테이션 2개 차시로 변경 확정함에 따라, 교수자용 ToT는 「HSS QI팀 과정계획안」 5장의 설계안 산출(권장 6시간 구성, 블록 A·A'·B·C·D·E·F)로 범위를 한정하였다. 둘째, 본 과제의 연구를 2트랙(효과성 평가 / 한국형 HSS 개념 정립 델파이)으로 병렬 추진하는 것을 확정하고 시스템 사고 교육모델 연구는 건양의대 주관 협력 연구로 두되, 콘텐츠 탑재가 2026년 8월 이후이므로 사업기간 내 학생 사전·사후 데이터 수집이 불가능한 점을 반영하여 효과성 평가의 범위를 '개발·운영 과정 기록' 중심으로 축소하고 '성균관대 파일럿 → 다대학 확대'의 단계적 로드맵으로 재구성하였다. 셋째, 같은 회의에서 대학별 HSS 추진 현황을 공유하여 확산 기반을 점검하였다.

대외 확산은 2회 이루어졌다. 2025년 11월 14~15일 KAMC Annual Meeting 중간발표에서 팀별 계획과 진행상황을 공유하였고, 2026년 7월 8일 제4회 교육부 성과공유세미나 대전충청권 HSS포럼에서 5개 발제(양은배·최용준·오윤채·심선희·이승희, 이 중 사업팀 소속 2건)를 통해 한국형 재맥락화의 언어("새 과목이 아니라 좋은 진료를 위한 렌즈", Cynefin·빙산 모델, 'Adaptive Systems Citizen' 인재상 등)를 확보하였다.

2. 회의·워크숍·세미나 개최 실적

가. 총괄

구분	횟수	연인원	주요 목적
전체회의(제1~5차 전체회의)	5회	46명	사업 프레임·도메인·산출물 범위의 합의와 공유
팀장회의	3회	12명	전체회의 사이의 실무 결단(도메인 확정, 양식·목표 구체화, 제작 방식 결정)
워크숍	1회	14명	1차년도 산출물 공유와 2차년도 방향 논의 (사업팀·건양대 공동 개최)
합계	9회	72명	—

나. 회차별

연번	구분	일자	장소	참석	논의·결정 사항
2	전체회의(제2차 전체 회의)	2025-08-29(금)	서울의대 국제관 원강홀(B1) + 줌	9명 — 최용준(팀장), 김새롬, 김세진, 나상훈, 이선영, 임윤주, 정승민, 조용수, 김강철(간사)	2팀 체제 결정, 도메인 3개 후보 검토
3	팀장회의 ①	2025-09-12(금)	온라인 Zoom	4명 — 최용준(팀장), 김세진, 지영아, 김강철(간사)	도메인 QI·SDOH 2개 확정(시스템 사고 제외), 팀장 지영아·김세진 배치. 11월 중간발표를 진행상황 정직 공유 방향으로 결정
4	전체회의(제3차 전체 회의)	2025-10-01(수)	온라인 ZOOM	9명 — 최용준(팀장), 김새롬, 김세진, 나상훈, 이선영, 임윤주, 정승민, 조용수, 김강철(간사)	2팀 배치 확정(QI: 지영아·정승민·이선영·나상훈 / SDOH: 김세진·김새롬·조용수·임윤주, 공동참여 최용준·김강철). 26개교 분석 결과 "주차별 콘텐츠 설계 공백" 확인, HSS 명시 9개교(강원·건국·건양·경북·동국·부산·아주·울산·한림)
5	팀장회의 ②	2025-12-02(화)	온라인 Zoom	4명 — 최용준, 김세진, 지영아, 김강철	2026년 5월까지 강의 콘텐츠 15개 제작 목표 최초 구체화. K-MedU 표준양식(강좌단위·모듈단위) 준수 결정. 신규 위원 합류 확인
6	전체회의(제4차 전체 회의)	2025-12-12(금)	서울의대 국제관 105호 4회의실	9명 — 최용준(팀장), 김새롬, 김세진, 나상훈, 이선영, 임윤주, 정승민, 지영아, 김강철(간사)	공유대학 플랫폼 현황 공유, 과정명·학점 단위·모듈 구조 확정, SDOH 모듈 골격 및 QI 6차시 구조 확정
7	팀장회의 ③	2026-02-24(화)	온라인 Zoom	4명 — 최용준, 김세진, 지영아, 김강철	촬영업체 변경. SDOH=외부 강사 촬영 / QI=내부 촬영으로 접근 분화. 양식 그대로 활용 방침 확정. HSS 조직 상설화 이사장 건의 방침

연번	구분	일자	장소	참석	논의·결정 사항
8	전체회의(제5차 전체 회의)	2026-04-22(수)	온라인 ZOOM	11명 — 최용준, 김새롬, 김세진, 양지현, 윤소정, 이선영, 이지혜, 임윤주, 지영아, 천경희, 김강철	SDOH 5개 모듈 9차시로 축소 확정, QI 6개 콘텐츠 6월 완료 확정(합계 15개). TOT 2개 → HSS 오리엔테이션 2개 변경. 연구 3건 계획 확정 — 본 과제 2트랙 + 건양의대 주관 협력 1건(시스템 사고 교육모델 DBR, 회의록 표기 「별도 과제로 추진」). 각 대학 HSS 추진 현황 공유
9	워크숍 (사업팀·건양대 공동 개최)	2026-07-31~08-01	대전 인터시티 호텔	14명 — 최용준, 김세진, 지영아, 천경희, 홍세리, 양지현, 최재정, 박영순, 박은희, 안준무, 하충원, 김민, 강재성, 김강철 (2일차 기준. 1일차 13개 기관 18명)	1일차 공동 추진 중인 시스템 사고 교육 콘텐츠의 개발 성과 공유, 교안 참조 포맷 구성과 학습자용·교수자용 워크시트 2벌 제작 방침 확정. 2일차 8개 대학이 HSS 교육 현황·도입 전략 공유, 1차년도 활동 경과 보고(김강철), 2차년도 이후 조직 형태(연구회·네트워크 구성 후 회장 선출) 논의

사업팀 회의록 9회분과 교육부 제출본 5건을 PDF로 보관하고 있다.

다. 워크숍 (2026-07-31 ~ 08-01, 대전)

1차년도 종료 직전 이틀에 걸쳐 사업팀과 건양대학교가 공동으로 워크숍을 개최하였다. 양일을 1회로 보아 회의 실적(연번 9)에 계상하였으며, 참석 인원은 2일차 기준 14명을 적용하였다. 다만 건양대 협력사업으로 개발 중인 시스템 사고 콘텐츠 사례가 한자리에서 공유되고 2차년도 방향이 논의된 자리이므로 확산 실적(VI장 5절)과 본 절에 함께 기술한다.

구분	1일차	2일차
일자·장소	2026-07-31(금) · 대전 인터시티 호텔 주피터홀	2026-08-01(토) · 동일 장소
명칭	[참키움 RISE] 의과대학 교육혁신 지원사업 — 협력대학 연계 시스템 사고 (Systems thinking) 콘텐츠 개발 성과 공유 워크숍	KAMC 「의료시스템과학 교육 콘텐츠 개발팀」 워크숍
개최	사업팀·건양대학교 공동 (1일차 소집 공문은 건양대 총장 명의, 사회 천경희)	사업팀·건양대학교 공동
참석	18명 · 13개 기관 (명단 19명·14개 기관 중 건국의대 1인 불참)	14명
성격	공동 추진 시스템 사고 콘텐츠의 개발 성과 공유 + 교안 참조 포맷 합의	대학별 HSS 교육 현황 라운드테이블 + 1차년도 경과 보고 + 2차년도 방향 논의

1일차 — 시스템 사고 콘텐츠 사례 공유. 프로그램 기준 Phase 0~3의 학년 단계별 사례 발표 10건이 편성되었다(윤소정·최재정·최용준·홍세리·강지연·나상훈·심선희·임만섭·오윤채·박영순). 발표자·주제 대응은 프로그램 기준이며, 녹음이 확보되지 않은 구간의 세션은 실시 여부가 확인되지 않았다. 확인된 범위의 논의는 다음과 같다.

① 교안 참조 포맷의 구성 순서(학습목표 → 워크시트 구성·시간 배분 → 기대 도달점 → 배경지식 노트)를 정하되, 제시 내용은 예시이며 학교 사정과 교수 재량에 따라 변경 가능함을 명시하기로 하였다.

② 학습자용·교수자용 워크시트를 동일 포맷 두 벌로 제작하기로 하였다. 실물 서식은 워크숍 이후 배포 예정이었다.

2일차 — 대학별 현황과 2차년도. 참석자 소속 대학의 HSS 교육 현황과 도입 계획을 약 2시간 16분간 공유하였다. 핵심 쟁점은 HSS를 독립 교과로 신설할 것인가, 기존 교과에 모듈로 편입할 것인가였다. 시수·책임교수 배정 부담을 이유로 기존 교과에 콘텐츠 기반 모듈로 넣는 방식('침투형' 또는 '인큐베이팅')을 지지하는 발언과, HSS 관점을 갖춘 담당자 확보가 어려우므로 기초 개론 과목 개설이 현실적이라는 발언이 함께 제시되었고 합의에는 이르지 않았다. 이어 1차년도 경과가 보고되었고(발표 김강철), 2차년도 이후 조직 형태로 연구회·네트워크 구성과 회장 선출을 통한 운영 이관 방향이 제시되었다.

회의록: 2일차는 사업팀 자체 행사이므로 정식 회의록 양식으로 별도 작성하였다. 양일 회의록은 녹음 전사본을 1차 근거로 작성하고 원문 대조 검증을 거쳤으며, 참석 인원은 일자별 참석자 명단에 따른다.

라. 연구 계획의 근거와 위상

연구 계획은 2026년 4월 22일 제5차 전체회의(제5차 전체회의) 안건 3 「HSS 교육 관련 연구 계획 발표 및 논의」에서 세 건이 제안되었다. 다만 회의 결정에 따라 위상이 다르다. 본 과제가 직접 수행하는 트랙은 2건이고, 세 번째는 건양의대가 주관하는 협력 연구다.

구분	연구	제안자	근거·설계	제5차 전체회의 결정
본 과제 트랙 ①	HSS 공유 교육과정 효과성 평가	김세진	가제 「공유대학 기반 공동 교육과정의 개발·운영 및 평가」. 저자진은 사업 전체 참여자 공동. 목적은 개발 과정 점검 / 개별 대학 운영 양상·어려움 파악 / 학습성과 사전·사후 비교 / 프로그램 적합성·실행 가능성 평가. 설계는 혼합연구(설문 문항 개발 + 사전·사후 평가, FGI)	추진. 단 "학교마다 교육 방법이 다른데 사전·사후 비교가 가능한가", "HSS 개념 정립이 선행되어야 한다", "대학별 편차로 효과성 검증은 시기상조"라는 의견이 제기되어 연구 범위를 '개발·운영 과정 기록'으로 축소하는 단계적 접근이 제안되었다
본 과제 트랙 ②	"한국형 HSS" 개념 정립 델파이	김강철	문제의식은 한국에 HSS에 대한 합의된 개념이 부재하다는 것. HSS를 교육과정 이전에 '관점/개념'으로 우선 다루어야 한다는 관점에서, 한국 의학교육 맥락의 재구성이 핵심. 방법은 델파이(예방의학·의료인문학·의학교육·임상 등 전문가 집단)	별도 트랙으로 교육과정 개발과 병행 추진. 연구진 확정 — 김강철(1저자), 김세진·지영아(주도적 참여), 최용준(공저자). 관심 연구자 자발 참여 방식
협력 연구(건양의대 주관)	시스템 사고 교육 모델 개발	천경희(건양의대)	건양의대가 주관해 개발 중인 Systems thinking 12주차 콘텐츠를 기반으로, 설계기반연구(DBR)를 통해 한국형 교육 모델을 개발·타당화. HSS 전반 내용을 사례·시나리오 기반으로 연계하고 수준별 배포	건양의대 주관 협력 연구로 추진 결정. 공동 연구 참여자는 천경희 교수가 모집 (회의록 원문 표기는 「별도 과제로 추진」)

시스템 사고 트랙 — 건양대와의 공동 추진

첫째, 영역 체계상 상보 관계다. HSS 12개 영역은 핵심 기능 7 · 기반 4 · 연결 1로 구성된다. 본 과제가 개발한 SDOH는 핵심 기능 영역 5, QI는 핵심 기능 영역 7이며, 시스템 사고는 이들을 관통하는 연결 영역 1이다. 즉 1차년도에 확보 또는 개발이 진행된 HSS 콘텐츠는 12개 영역 중 「핵심 기능 2영역 + 연결 1영역」이며, 나머지 9개 영역은 공백으로 남는다. 다만 도구 수준의 접합은 아직 이루어지지 않았다. 빙산 모델·인과 루프·레버리지 포인트는 시스템 사고 트랙 내부의 공통 분석 도구이고(1일차 회의록 §4-§7-§8-§9), 본 과제 SDOH·QI 콘텐츠는 각각 모듈 구성과 SQUIRE 2.0·TBL이라는 별개의 프레임을 쓴다. 두 트랙의 도구 수준 접합은 2차년도 과제로 남는다.

둘째, 개발 인력이 본 과제 연구진이다. 2026년 7월 31일 성과 공유 워크숍 참석자 18명 중 10명이 본 과제 연구진 18인에 포함된다(최용준·김강철·김세진·지영아·나상훈·천경희·윤소정·강지연·양지현·홍세리). 시스템 사고 콘텐츠의 개발자 상당수가 본 과제의 SDOH·QI 콘텐츠 개발자와 동일 인물이다. 다만 산출물 양식은 서로 다르다 — 본 과제는 K-MedU 표준양식으로 제출을 마쳤고, 시스템 사고 트랙은 워크숍에서 정한 교안 참조 포맷을 쓴다.

이에 따라 시스템 사고 콘텐츠는 재원은 건양대학교, 추진은 공동으로 기재한다. 관련 설계기반연구(DBR)는 제5차 전체회의 결정에 따라 건양의대가 주관하는 협력 연구로 계상한다.

한편 제5차 전체회의에서는 위 세 건 외에 "HSS 주요 개념(시스템 사고·가치 기반 의료 등 미국 중심 개념)에 대한 의료진·학생·세대 간 수용·해석 차이 연구"가 추가로 제안되었으나, 별도 어젠다로 고려하는 수준에서 논의가 종료되었다.

근거 문서: 「HSS 교육과정 개발 및 적용 회의록_0422」 안건 3(3-1~3-3), 「첨부3. HSS 교육과정 개발 및 적용_전후 비교 연구 계획안」(트랙 ①의 계획안)

3. 조사·시범운영 추진 실적

구분	대상	규모	결과 요약
수정사업계획서 분석 (2025-10-01, 제3차 전체회의)	교육혁신 지원사업 참여 의과대학이 제출한 수정사업계획서	37개교 중 26개교 분석	HSS를 명시한 대학은 9개교. 다수 대학이 계획서에 HSS를 언급하면서도 주차별 콘텐츠 설계는 부재한 "설계 공백" 상태임을 확인. 본 과제의 개발 표적을 계획 수준의 선언을 실제 차시 콘텐츠로 전환하는 것으로 좁히는 근거가 됨
현황 공유(회의 세션) — 대학별 HSS 교육 현황·도입 전략 라운드테이블 (2026-08-01, 워크숍 2일차)	워크숍 참석 의과대학	약 2시간 16분, 8개 대학 발표(한림·차의전원·가톨릭관동·건양·동아·아주·성균관·충남)	도입 방식이 독립 교과 신설과 기존 교과 내 모듈 편입 두 방향으로 병존하였다(합의 미도출). 한림대는 '의료시스템과학' 과목을 임상실습 전 1주로 확대(2026), 성균관대는 라이즈 사업 '지역사회 진로현장 실습'에 HSS 관점 лек처를 선행 배치, 충남대는 '인문사회의학 1~7' 중 '의료와 사회' 차시를 공유 콘텐츠 적용 지점으로 검토 중이다. 교원 확보와 교수개발이 공통 애로로 확인되었다
대학별 HSS 교육 추진 현황 공유 (2026-04-22 제5차 전체회의)	사업 참여 의과대학	현황 공유 9개교(한림·인제·동아·충남·부산·서울·건국·성균관·건양)	자체 과목 운영(한림 '의료시스템과학' 2024~), 신설 예정(건국 '지역사회의학' 2026, 충남 의료인문학교실 2026-03), 기존 과목 내 포함(성균관 예방의학·인문사회의학), 6년제 교육과정 반영(서울 6년제 위원회, 건양 6년 나선형), 공유 콘텐츠 활용 의향(동아 비교과, 부산 2학점 선택과목) 등 유형별 편차 확인. 부산의대는 강의 외 워크시트·활동 자료의 동반 개발을 요청

4. 계획 대비 변경사항 및 사유

변경 항목	당초 계획	변경 내용	변경 사유
① SDOH 트랙 차시 수	9차시	10차시 — 촬영 단계에서 한 개 모듈을 2차시로 나누어 촬영	협회 공유 콘텐츠 편성 방침(온라인 영상 1차시 25~35분 = 콘텐츠 1개)에 맞춘 조정
② 후속 연구 추가	계획 없음	연구 3건 계획 확정 — 공유 교육과정 효과성 평가, 한국형 HSS 개념 정립 델파이, 시스템 사고 교육모델 설계기반연구(건양의대 주관 협력)	콘텐츠 개발 과정에서 축적된 자료를 학술 성과로 연결하기 위해 2026-04-22 제5차 전체회의에서 추가 결정. 실행은 2차년도 이월

05 주요 결과 및 성과물

1. 핵심 결과 요약

1. 1차년도 핵심 산출물인 공유대학 탑재 영상 콘텐츠는 SDOH 10차시 + QI 6차시, 총 16차시로 구성이 확정되고 강사 배치를 마쳐 촬영에 진입하였다. 다만 이수치는 2026년 4월 22일 제5차 전체회의에서 최종 재확정된 과업 범위와 강사 배치의 확정을 기준으로 한 것이며, 촬영·제작은 당초 2026년 6월 완료 목표에서 지연되어 사업기간(2026-08-31) 내 완료를 목표로 진행 중이고 공유대학(K-MedU) 플랫폼 탑재는 2026년 8월 이후로 예정되어 있다.
2. 두 개 도메인 트랙은 7개 모듈(SDOH 5모듈, QI 2모듈)로 구조화되었고, K-MedU 표준양식에 따른 (통합)강의·모듈 개설신청서 및 강의·모듈 계획서 2건(트랙별 통합문서 1건)으로 문서화되어 2026년 4월 21일 제출을 완료하였다.
3. QI 트랙은 단일 강의가 아니라 운영 패키지로 설계되었다. SQUIRE 2.0을 실습·평가의 표준 프레임으로 채택하고, Flipped Learning과 TBL을 결합하며, 압축형 4시간 / 확장형 8시간의 이중 운영 트랙과 교수자용 ToT(권장 6시간)를 함께 확정하였다. 다만 부속 평가도구 3종(TBL 활용지, SQUIRE 2.0 체크리스트·루브릭, QI 프로젝트 RFP 양식)은 「과정계획안」 산출물 목록에 명시된 단계이고 실물이 확인되지 않아 산출물로 계상하지 않았다. 완성은 2차년도 과제다.
4. 성과의 대외 확산은 대외 발표 2회(2025년 11월 KAMC Annual Meeting 중간발표, 2026년 7월 8일 제4회 교육부 성과공유세미나 대전충청권 HSS포럼)와 건양대와 공동 개최한 2일간의 워크숍(2026년 7월 31일~8월 1일 — 1일차 18명·13개 기관, 2일차 14명)으로 이루어졌고, 2026년 4월 회의와 8월 1일 라운드테이블에서 각 대학이 HSS 추진 현황을 공유하였다. 사업 기간 중 공식 회의는 9회(전체회의 5회, 팀장회의 3회, 워크숍 1회)이며, 누적 연인원은 72명이다.
5. 연구는 본 과제 2트랙(효과성 평가·한국형 개념 정립 델파이)과 건양의대 주관 협력 1건(시스템 사고 교육모델 DBR)의 계획이 확정된 단계다. 콘텐츠 탑재가 2026년 8월 이후여서 사업기간 내 학생 대상 사전·사후 데이터 수집이 불가능하므로, 효과성 평가는 '개발·운영 과정 기록' 중심으로 조정하고 실행은 차년도로 이월하였다.
6. 1차년도 종료 시점에 완료되지 않아 추후 보완이 필요한 항목은 ① 공유대학(K-MedU) 영상 탑재와 ② 건양대 주관 시스템 사고 콘텐츠 두 가지다. 두 항목 모두 사업팀 선행 과업은 마쳤으나 완료 시점이 외부 일정(플랫폼 개설·타 사업 개발 일정)에 걸려 있다. 상세와 보완 계획은 6절에 정리하였다.

2. 산출물 총괄표

구분	연번	산출물명	유형	규격	완료 시점	완료 여부
주요 성과물(KPI 1·2·3)	1	SDOH 강의 영상 콘텐츠 세트 「건강의 사회적 결정요인」	강의콘텐츠	5모듈 10차시, 차시당 25~35분, 100% 온라인	설계·강사 배치 확정 2026-04-22 / 촬영 당초 2026-06 목표(지연, 사업기간 내 완료 목표)	설계 100%, 제작 진행 중
주요 성과물(KPI 1·2·3)	2	QI 강의 영상 콘텐츠 세트 「환자안전을 위한 질향상」	강의콘텐츠	2모듈 6차시, 차시당 25~35분, 온·오프라인 혼합	설계 확정 2026-04-21 / 촬영 당초 2026-06 목표(지연, 사업기간 내 완료 목표)	설계 100%, 제작 진행 중
주요 성과물(KPI 1·2)	3	차시별 강의자료	발표 슬라이드(PPT·PDF)	16차시 각 1건(SDOH 10 + QI 6), 강의 영상과 동반 제작	영상 촬영과 동시 진행	제작 진행 중
중간 산출물	4	SDOH (통합)강의·모듈 개설 신청서 + 강의·모듈 계획서	교육과정 설계문서	K-MedU 강좌단위 양식, 온라인 14차시+평가 1차시=15차시 1학점 기준	2026-04-21	완료(100%)
중간 산출물	5	QI (통합)강의·모듈 개설신청서 + 강의·모듈 계획서	교육과정 설계문서	K-MedU 모듈단위 양식(다중모듈 2개), 온라인 6차시	2026-04-21	완료(100%)
중간 산출물	6	HSS QI팀 과정계획안	교육과정 설계문서	블록형 6단위(A~F), 이론 4h+실습 4h=8h, 압축형 4h/확장형 8h 이중 트랙	2025-12-12(제4차 전체회의 [첨부6.1])	완료(100%)
중간 산출물	7	HSS QI팀 과정계획안 검토 의견서	검토문서	6개 항목(개요·목표·성과역량·아키텍처·ToT·산출물) 검토의견 회람 양식	2025-11-10	완료(100%)
중간 산출물	8	HSS-SDOH 학습성과 및 목표 작업양식	교육과정 설계문서	트랙-모듈-차시 3층 학습성과 매핑	2025-11-10(수정본)	완료(100%)

구분	연번	산출물명	유형	규격	완료 시점	완료 여부
별도 추가	9	연구계획 3건(본 과제 2트랙 + 건양의대 주관 협력 1건)	연구계획	효과성 평가·한국형 HSS 델파이 병렬 추진 계획안 + 시스템 사고 교육모델 DBR(건양의대 주관 협력 연구)	2026-04-22 제5차 전체회의 제안·논의	계획 확정 100% / 실행 차년도 이월

3. 주요 산출물 상세

3-1. SDOH 강의 영상 콘텐츠 세트 「건강의 사회적 결정요인(Social Determinants of Health)」

항목	내용
산출물명	HSS-SDOH 공유 강의 영상 콘텐츠 세트 (5개 모듈 10차시, 차시당 25~35분, 100% 온라인)
개발 목적과 활용 대상	학습성과 「건강의 사회적 결정요인을 고려하여 진료할 수 있다」의 달성을 목표로, 회원 의과대학이 공통으로 사용할 수 있는 온라인 강의 자산을 확보한다. 활용 대상은 학부 임상실습 단계 학생이며, 관련 KAMC 졸업성과(KGO)는 1(환자진료)·2(지식적용과 활용)·5(전문직업성)이다. 개별 대학이 교과·비교과 어느 형태로도 도입할 수 있도록 차시 단위로 분절 활용이 가능하게 구성하였다.
개발 절차	① 2025-08-29 제2차 전체회의에서 2팀 체제 구성 및 도메인 3후보 검토 → ② 2025-09-12 팀장회의에서 SDOH를 QI와 함께 2개 도메인으로 최종 확정(시스템 사고 제외), 팀장 김세진(동아의대) → ③ 2025-11-10 「HSS-SDOH 학습성과 및 목표 작업양식」으로 트랙-모듈-차시 3층 학습성과 매핑 → ④ 2025-12-02 팀장회의에서 1차년도 강의 콘텐츠 15개 제작 목표 구체화 및 K-MedU 양식 준수 결정 → ⑤ 2025-12-12 제4차 전체회의에서 과정명·학점단위·모듈구조 확정 → ⑥ 2026-03-27 1차 제출본, 2026-04-21 최종 제출 → ⑦ 2026-04-22 제5차 전체회의에서 '5개 모듈, 9차시로 축소 개발' 최종 재확정 → ⑧ 강사 확정 후 촬영 진행(당초 2026-06 완료 목표, 지연되어 사업기간 내 완료 목표)
주요 구성	모듈 1 인구집단과 개인 건강의 사회적 결정요인(정최경희, 2차시) / 모듈 2 건강의 구조적 결정요인과 사회적 결정요인(윤태호, 2차시) / 모듈 3 사회적 결정요인의 영향력(Howard Waitzkin, 2차시) / 모듈 4 개선 방법(장숙량, 2차시) / 모듈 5 사회적 결정요인을 고려한 치료 및 돌봄(추혜인·여라, 2차시). 개발 담당 김세진(동아의대), 참여 김새롬(인제의대)·임윤주(경희의대)·조용수(전남의대). 외부 강사 컨택은 인제의대 김새롬 교수가 창구를 맡았다.
타당화 근거	① 2025-10-01 제3차 전체회의에서 26개교 수정사업계획서를 분석하여 26개교 수정사업계획서 분석 결과를 공유하였다(콘텐츠 수준의 구체적 제안 부족). ② 학습성과-KGO 매핑(KGO 1·2·5)으로 졸업성과 체계와의 정합성을 확보하였다. ③ 교재는 강의 슬라이드, Skochelak et al.(2021) 2nd ed., 이종태 외(2025) 번역서 3종을 지정하였다. ④ 모듈 구성은 2026-04-22 제5차 전체회의 회의록 「합의 사항(최종 구성)」 표로 확정되었다.
활용 및 배포	공유대학(K-MedU) 플랫폼 탑재를 통해 회원 의과대학에 공유하며, 탑재 시점은 2026년 8월 이후이다. 부산의대는 의학과 2학점 선택과목 활용을 논의 중이고, 동아의대는 비교과 또는 자유선택과정(소그룹) 활용을, 건국의대는 2026년 신설한 '지역사회의학' 수업과의 연계를 검토하고 있다.
한계	① 원안(6개 모듈, 온라인 14차시+평가 1차시, 총 15차시 1학점)에서 10차시로 재확정되어, 학점 단위 운영을 전제한 설계와 확정 차시 수가 어긋난다. 학점 단위 재설계 여부는 2차년도 검토 과제다. ② K-MedU 제출본(SDOH, 2026-04-21)이 축소 전 기준으로 작성되어 있고 개정본은 작성되지 않았다(2026-08-02 확인) — 2차년도 개정 대상이다. ③ 축소 과정에서 옹호활동 모듈(인제의대 담당 예정)이 범위에서 제외되었다. ④ 플랫폼 탑재가 2026년 8월 이후여서 사업기간 내 학생 대상 효과 측정이 불가능하다.

3-2. QI 강의 영상 콘텐츠 세트 「환자안전을 위한 질향상 / 질관리(Quality Improvement for Patient Safety)」

항목	내용
산출물명	HSS-QI 공유 강의 영상 콘텐츠 세트 (2개 모듈 6차시, 차시당 25~35분, 온·오프라인 혼합) 및 이를 감싸는 운영 설계 패키지(과정계획안)
개발 목적과 활용 대상	환자안전·질향상을 HSS의 관점에서 다루는 공유 교육과정을 확보한다. 활용 대상은 학부 임상실습전 및 임상실습 단계 학생이며, 관련 KGO는 1(환자진료)·3(소통과 협력), KAMC 성과역량 7.1.1·7.1.2·7.2.2·7.2.3에 매핑된다. 온라인 영상만 단독 활용하는 방식과, 실습 블록을 결합해 4시간(압축형) 또는 8시간(확장형)으로 운영하는 방식을 모두 지원한다.
개발 절차	① 2025-09-12 팀장회의에서 QI 도메인 확정, 팀장 지영아(성균관대의대) → ② 2025-10-24 QI 소위원회 1차에서 과정명 확정, SQUIRE 2.0 채택, Flipped Learning+TBL 확정, 압축 4h/확장 8h 이중 트랙 결정, 「과정계획안」과 검토의견서로 과정명·SQUIRE 2.0·Flipped Learning+TBL·압축 4h/확장 8h·ToT 권장 6h·필수 산출물 3종·강사 배치를 확인 → ③ 2025-11-10 QI 소위원회 2차(문서 회람 방식)로 과정계획안 검토의견서 6개 항목 취합 → ④ 2025-12-02 팀장회의에 과정계획안 첨부·확정 → ⑤ 2026-02-24 팀장회의에서 6차시(QI 4 + HSS 오리엔테이션 2) 구성 유지 확인 → ⑥ 1차 제출본(2026-04-14)을 거쳐 2026-04-21 최종 제출 → ⑦ 2026-04-22 제5차 전체회의에서 '2026년 6월까지 6개 콘텐츠 개발 완료' 확정, 내부 촬영 방식으로 진행
주요 구성	모듈 1 「HSS와 HSS관점에서 QI」(1~3차시): HSS Orientation 1·2, HSS 관점에서 QI. 모듈 2 「QI: Case Based Learning」(4~6차시): SQUIRE 2.0 및 평가, CBL 1·2. 평가는 총괄평가(시험 1회·과제 1회)와 형성평가(차시별 퀴즈 2문항)로 구성한다. 학생용 아키텍처는 블록 A~F 6단위(이론 4h+실습 4h), 교수자용 ToT는 권장 6h(A·A'·B·C·D·E·F, 이 중 교수자 전용 신규개발 A'/E/F 3h)이다. 운영책임은 권장 교수 3명(예방의학·의학교육 분야)+강좌조교 1명. 개발 담당 지영아(성균관대의대), 참여 나상훈(서울의대)·정승민(한림의대), 자문 이선영(서울의대).
타당화 근거	① SQUIRE 2.0을 실습·평가의 표준 프레임으로 채택하여 국제 보고지침에 근거한 평가 기준을 확보하였다(2025-10-24 QI 소위 1차 결정). ② KAMC 성과역량 7.1.1·7.1.2·7.2.2·7.2.3 매핑으로 역량 체계와의 정합성을 확보하였다. ③ 공유교육 원칙(동영상 30~35분, 15분 2 package 편성)을 준수하였다. ④ 교재는 KAMC 번역서 『의료시스템과학: 의학교육 변화를 위한 이니셔티브』를 지정하였다. ⑤ 설계안은 2025-11-10 팀 내 회람 검토의견서(6개 항목)를 거쳐 확정되었다.
활용 및 배포	K-MedU 플랫폼 탑재(2026년 8월 이후) 후 회원교 공유. 성균관대의대 파일럿 후 다대학 확대 방안이 검토되었다(2026-02-24 팀장회의). 부산의대는 2~3학점 확장 활용을 전제로 강의 외 워크시트·활동 자료의 동반 개발을 사업팀에 요청하였다(2026-04-22).

4. 학술적 성과

제목	유형	학술대회명	일자	상태
HSS 교육과정 개발 사업 중간발표	학술대회 포럼 발표(중간발표), 발표자 최용준	KAMC Annual Meeting 2025	2025-11-14~15	발표 완료
대전충청권 HSS포럼 발제	세미나 발제, 발표자 최용준	제4회 교육부 성과공유세미나 대전충청권 HSS포럼	2026-07-08	발표 완료
대전충청권 HSS포럼 발제	세미나 발제, 발표자 이승희	제4회 교육부 성과공유세미나 대전충청권 HSS포럼	2026-07-08	발표 완료
시스템 사고 교육 콘텐츠 학년 단계 (Phase 0~3)별 사례 발표	워크숍 사례 발표(프로그램 기준 10건) — 윤소정·최재정·최용준·홍세리·강지연·나상훈·심선희·임만섭·오윤채·박영순	사업팀·건양대학교 공동 워크숍 1일차	2026-07-31	발표 완료
「2025년 7월 이후 의대협회 HSS팀 의 활동 경과와 과제」	워크숍 발표(1차년도 경과 보고), 발표자 김강철	사업팀·건양대학교 공동 워크숍 2일차	2026-08-01	발표 완료
공유 교육과정 효과성 평가 연구	연구계획(혼합연구: 사전·사후 설문 + FGI, Rasch 모델 적용 검토), 제안 김세진, 사업 전체 참여자 공저	—	계획 확정 2026-04-22	계획 확정 / 실행 차년도 이월(범위를 '개발·운영 과정 기록' 중심으로 조정)
한국형 HSS 개념 정립 델파이 연구	연구계획(2~3라운드 델파이, 예방의학·의료인문학·의학교육·임상 전문가 패널), 1저자 김강철, 주도참여 김세진·지영아, 공저 최용준	—	계획 확정 2026-04-22	계획 확정 / 실행 차년도 이월
시스템 사고 교육모델 설계기반연구(DBR)	연구계획 — 건양의대 주관 협력 연구, 제안·주도 천경희, 건양의대 시스템 사고 콘텐츠 기반	—	계획 확정 2026-04-22	계획 확정 / 기반 콘텐츠 2026-07-31 완료 목표

※ 2026-07-08 대전충청권 HSS포럼은 총 5개 발제(양은배·최용준·오윤채·심선희·이승희)로 구성되었고, 이 중 본 사업팀 소속 발제는 2건이다.

5. 확산·홍보 실적

구분	내용	대상	일자
대외 발표	KAMC Annual Meeting 중간발표 「Health systems science 교육 콘텐츠 개발 연구」(최용준 팀장, 30쪽) — '무리한 속도 대신 계획과 진행상황을 정직하게 공유'하는 방향(2025-09-12 팀장회의 결정). 발표 구성: 팀 소개(10인) / HSS 개념(세 번째 기둥, 한국적 맥락 정의) / 영역 체계(핵심 기능 7 · 기반 4 · 연결 1) / 사례 예시(가치기반 의료 — 중환자실 일일 홍보방사선 촬영) / 진도 4항목(선행연구 검토, 콘텐츠 개발, 도입 추진 대학 지원, 연구 수행) / 향후 계획 4항목. 사업 종료 후 과제로 "전국 차원의 의료시스템과학 교육 조직·인력·재정·활동"과 "도입 대학 간 교류와 협력"을 이 시점에 이미 제기	회원 의과대학 및 학술대회 참가자	2025-11-14~15
대외 발표	제4회 교육부 성과공유세미나 대전충청권 HSS포럼 — 5개 발제를 통해 한국형 재맥락화 필요성, '새 과목이 아니라 좋은 진료를 위한 렌즈'라는 개념 규정, Cynefin·빙산 모델, 기존 통합과정 저비용 도입 실증, 'Adaptive Systems Citizen' 인재상 등 개념 언어 확보	교육부 사업 참여교 및 대전충청권 의과대학	2026-07-08
정기 간행	의료시스템과학 뉴스레터 3호 발간(이메일 뉴스레터, 편집인 최용준 팀장) — #1 「의료시스템과학 뉴스레터를 시작하며」(HSS 문헌 목록 공유), #2 「의료시스템과학은 통합 플랫폼」(이종태 KAMC 이사장 인터뷰 — "개별 대학이 모든 HSS 교육 인프라를 독자적으로 구축하는 것은 현실적으로 매우 어렵다. KAMC 차원의 표준 모형 제시가 선행되어야 한다"), #3 「STEEEP를 아십니까?」(학생뿐 아니라 교육자의 STEEEP 이해 필요성 제기)	구독 신청자(사업 참여 위원 및 관심 의과대학 교원)	#1 2025-12-26 / #2 2026-01-05 / #3 2026-01-26
대학 간 현황 공유	제5차 전체회의 「각 대학 HSS 교육 추진 상황 공유」 — 9개교가 교내 추진 현황 발표(한림·인제·동아·충남·부산·서울·건국·성균관·건양), 연구진 소속 기준으로 14개교	사업 참여 대학	2026-04-22
표준양식 확산	공유대학팀(부산의대 임선주·최효선 교수) 배포 K-MedU 강의개발계획서 양식 2종(강좌단위/모듈단위)을 수령하여 SDOH=강좌단위, QI=모듈단위로 분화 적용, 양식 수정 요청 없이 그대로 활용하는 방침 확정 후 두 트랙 최종안 제출	공유대학팀 및 타 세부과제	수령 2025-12-02 / 방침 확정 2026-02-24 / 제출 2026-04-21

구분	내용	대상	일자
대학 요청 반영	부산의대의 요청(2~3학점 확장 활용을 위한 워크시트·활동 자료 동반 개발)을 사업팀 검토 사항으로 접수	부산의대	2026-04-22
워크숍 (1일차)	시스템 사고 콘텐츠 개발 성과 공유 워크숍(사업팀·건양대 공동 개최, 대전 인터시티 호텔) — 학년 단계(Phase)별 시스템 사고 개발 사례 발표, 교안 참조 포맷 구성 합의, 학습자용·교수자용 워크시트 2벌 제작 방침(실물 배포는 워크숍 이후), 향후 제작분의 '의료시스템과학' 표기에 반대 의견 없음(명시적 합의 선언은 미확인, 2일차에 재논쟁)	18명 · 13개 기관 (본 과제 연구진 10명 포함)	2026-07-31
워크숍 (2일차)	KAMC 「의료시스템과학 교육 콘텐츠 개발팀」 워크숍 — 대학별 HSS 교육 현황·도입 전략 라운드테이블(약 2시간 16분, 8개 대학 발표), 1차년도 경과 보고(발표 김강철), 2차년도 이후 조직 형태(연구회·네트워크 구성 및 회장 선출을 통한 운영 이관) 논의	14명	2026-08-01
사업 내부 공유	회의 9회 개최(전체회의 5회 46명 + 팀장회의 3회 12명 + 워크숍 1회 14명), 누적 연인원 72명. 도메인 소위원회는 트랙별 수시 운영으로 별도 계상하지 않음	사업 참여 위원	2025-07-24 ~ 2026-08-01
플랫폼 탑재(예정)	개발 콘텐츠 16차시의 공유대학(K-MedU) 플랫폼 탑재	회원 의과대학 40개교	2026-08 이후

가. 의료시스템과학 뉴스레터 (3호)

본 과제의 확산 활동 중 유일한 간행물은 최용준 팀장이 편집·발행한 「의료시스템과학 뉴스레터」이다. 이메일 뉴스레터 플랫폼(Stibee)을 통해 2025년 12월 26일 창간호를 발행한 이후 2026년 1월 26일까지 3호가 발행되었으며, 발행 주기는 부정기이다. 발행 주체가 협회나 사업팀이 아니라 팀장 개인 채널이므로 본 보고서는 이를 사업 성과지표가 아닌 자발적 확산 활동으로 분류한다.

뉴스레터는 매 호 3개 항목(주제 제시 / 문헌 또는 용어 / 소식)과 독자 의견 수집 CTA로 구성되며, 각 항목은 편집인의 블로그 상세 글로 연결된다. 하단에는 "의대협회 HSS팀 비공식 부정기 뉴스레터"라는 자기 규정이 명시되어 있다. 공개 아카이브(<https://page.stibee.com/archives/462597>)에서 전 호를 열람할 수 있다.

호	발행일	제목	구성 항목	핵심 내용
#1	2025-12-26	의료시스템과학 뉴스레터를 시작하며	① 뉴스레터를 시작하며 ② 문헌 ③ 소식	창간 취지("HSS에 대하여 더 많은 논의가 이루어지고 더 좋은 정보가 공유되며 더 실질적인 교육이 실천되기를 희망합니다"). HSS팀 구성 후 첫 작업이 문헌 목록 작성·공유였음을 기록하고, 국내 자료 중 KAMC 웹사이트 HSS 페이지를 가장 중요한 자료로 지목. 2025-11-14~15 KAMC 학술대회 중간발표 소식 전달
#2	2026-01-05	의료시스템과학은 통합 플랫폼	① 인터뷰 ② 용어 ③ (소식)	이종태 KAMC 이사장 인터뷰 — "개별 대학이 모든 HSS 교육 인프라를 독자적으로 구축하는 것은 현실적으로 매우 어렵습니다. 그래서 저는 KAMC 차원의 표준 모형 제시가 선행되어야 한다고 봅니다." 아울러 '의료 시스템'이라는 용어가 한국에서 통상 '국가' 단위로 이해되는 문제를 다룸

6. 1차년도 종료 시점 미완 항목

1차년도 종료 시점(2026-08-31)에 완료되지 않아 추후 보완이 필요한 항목은 두 가지다. 두 항목 모두 사업팀이 이행할 수 있는 선행 과업은 마쳤으나 완료 시점을 사업팀이 단독으로 통제하지 않는다.

항목	1차년도 종료 시점 상태	미완 사유	보완 시점·주체
① 공유대학(K-MedU) 영상 탑재	콘텐츠 16차시(SDOH 10 + QI 6) 설계·강사 배치 확정, 촬영 진행. 탑재 0건	공유대학 플랫폼의 개설·운영 일정에 종속된다. 사업팀 선행 절차(K-MedU 표준양식 개설신청 서류 2건)는 2026-04-21 제출로 종료되었다. 2025-12-12 제4차 전체회의에서 플랫폼이 업체 선정·계약 마무리 단계임이 공유되었다	2026-08 이후 · 사업팀 + 공유대학팀(부산의대 임선주·최효선)

보완 방법. ①은 촬영·편집 잔여분 완료 → 공유대학팀 품질 심사 대응 → 탑재의 순서로 진행하며 2차년도 ① 과제에 해당한다(X II장). ②의 완료 시점과 이후 처리는 건양대 일정에 따르며 미정이다.

보고서 기재 원칙. 본 보고서는 위 두 항목을 완료로 기재하지 않는다. 산출물 총괄표(2절)의 연번 1~3, 성과지표 KPI 3-4(VII장 1절), 자체평가(VII장 3절)의 해당 서술은 모두 '진행' 또는 '대기'로 표기되어 있으며, 최종 상태는 2차년도 보고 시점에 갱신한다.

7. 산출물 저작권 및 관리

산출물	저작권 귀속	공개 범위	관리 주체
SDOH·QI 강의 영상 콘텐츠 16차시	미확인 — 협약·계약 문서 대조 후 확정	공유대학(K-MedU) 플랫폼을 통한 회원 의과대학 공유	KAMC 사무국 · 공유대학팀(부산의대) · 트랙별 팀장(김세진·지영아)
교육과정 설계문서 (SDOH·QI 개설신청서+계획서, 과정계획안, 검토의견서, 학습성과 작업양식)	미확인 — 협약·계약 문서 대조 후 확정	사업 참여교 및 회원교 요청 시 제공	과제 책임자 최용준(한림의대) · 간사 김강철(서울의대)
연구계획 3건 및 향후 산출 데이터	미확인 — 협약·계약 문서 대조 후 확정	학술 논문·학술대회 발표를 통한 공개	트랙별 책임자(김세진 / 김강철). 건양의대 주관 협력 연구인 시스템 사고 교육모델 DBR은 건양의대(천경희)
회의록·경과 문서 등 사업 관리 문서	미확인 — 협약·계약 문서 대조 후 확정	내부 한정	간사 김강철(서울의대)

06 성과지표 달성도 및 자체평가

1. 성과지표 달성도

1.1 지표 체계와 판정 기준

본 장의 성과지표는 KAMC 「의학교육혁신사업 핵심성과지표(안)」(2025. 10. 12.) 전략목표 G5 의료시스템과학(HSS) 교육과정 개발 및 적용의 KPI를 따른다. 1차년도(Y1)에 해당하는 KPI는 5개이며, 나머지 1개는 2차년도(Y2) 지표다. 지표 체계는 표장 2절에 제시하였고, 본 절은 달성도 판정과 그 해석을 다룬다.

KPI가 완료 여부(Y)로 정의되어 있으므로 완료 · 진행 · 대기 · 해당 없음의 네 단계로 판정하였다. 판정 근거는 회의록·제출 문서·배포 양식 등 1차 자료에 한정하였으며, 근거가 확인되지 않은 항목은 임의로 추정하지 않았다.

1.2 KPI 달성도 요약

연번	KPI명 (KAMC 지표)	연차	판정	비고
1	SDOH 교육콘텐츠(교안·평가 포함) 개발 완료	Y1	설계 완료 · 제작 진행	교안은 차시별 발표 슬라이드 10건으로 영상과 동반 제작. 평가도구와 오프라인 활용 자료(워크시트·활동자료) 개발은 2차년도 이월
2	QI 교육콘텐츠(교안·루브릭 포함) 개발 완료	Y1	설계 완료 · 평가도구 일부 미완	교안은 차시별 발표 슬라이드 6건으로 영상과 동반 제작. 평가도구 3종은 강의 완성 시점에 수합 예정
3	HSS 동영상 콘텐츠 제작 완료	Y1	제작 진행	국외 강사 1인은 줌 원격 촬영으로 완료. 잔여는 국내 강사 촬영·편집
4	HSS 동영상 공유대학 탑재 여부	Y1	대기 — 플랫폼 일정 종속	개설신청 서류 2건 제출 완료(2026-04-21). 탑재는 K-MedU 플랫폼 개설 일정에 따라 2026-08 이후
5	교육과정 및 연구성과 확산 활동 수행	Y1	완료	학술 발표 2회, 워크숍 2일, 뉴스레터 3호, 대학별 현황 공유 9개교
6	공유대학 탑재한 HSS 동영상 보완 및 확산 여부	Y2	해당 없음	2차년도 지표
별도추가	후속 연구 3건	—	계획 확정 · 실행 이월	KPI에 없던 항목. 공유 교육과정 효과성 평가, 한국형 HSS 개념 정립 델파이, 시스템 사고 교육모델 설계기반 연구(건양의대 주관 협력)

1차년도 KPI 5개 중 1개 완료, 3개 진행, 1개 대기. 다만 이 수치만으로는 1차년도 수행을 판단하기 어렵다. KPI 1~4가 하나의 산출 계열(콘텐츠 설계 → 제작 → 탑재)을 단계별로 끊어 놓은 지표이기 때문이다. 같은 계열을 단계로 보면 설계는 완결되었고, 제작은 진행 중이며, 탑재는 대기다.

사업팀 이행 범위의 관점. 1차년도에 사업팀이 자체적으로 완결할 수 있었던 과업 — 개발 도메인 확정(2025-09-12), 팀 배치(2025-10-01), 모듈·차시 구성과 강사 배치(2026-04-22), 학습성과 3층 매핑(2025-11-10), K-MedU 표준양식 문서 제출(2026-04-21), 대외 확산 활동, 건양대와 공동 개최한 워크숍

(2026-07-31~08-01) — 은 모두 이행되었다.

공동 추진 사항. 시스템 사고(연결 영역) 교육 콘텐츠는 건양대학교와 공동으로 추진 중이며, 2026년 7월 31일 워크숍에서 성과를 공유하였다(V장 3절). 개발이 진행 중이어서 모듈·차시 수는 확정되지 않았다.

미완으로 남은 두 지표는 성격이 다르다.

- KPI 3(동영상 제작 완료) — 강사 개별 일정에 종속된다. 사업팀은 강사 섭외·계약·촬영 방식 분화까지 이행하였고, 국외 강사(Howard Waitzkin) 촬영은 줌 원격 촬영으로 진행하여 2차시 분량을 확보하였다.
- KPI 4(공유대학 탑재) — 공유대학 플랫폼의 개설·운영 일정에 종속된다. 2025-12-12 제4차 전체회의에서 플랫폼이 업체 선정·계약 마무리 단계임이 공유되었고, 탑재 가능 시점은 2026-08 이후다. 사업팀이 이행할 수 있는 선행 절차(표준양식 개설신청 서류 제출)는 2026-04-21에 종료되었다.

KPI 3은 촬영 진행 중이고, KPI 4는 K-MedU 플랫폼 개설 일정에 따라 2026-08 이후 탑재 예정이다.

2. 목표 미달·초과 항목 분석

지표	구분	원인	보완 계획
KPI 1 SDOH 교육콘텐츠 개발	미달(설계 완료·제작 진행)	SDOH 트랙이 100% 온라인 강의로 설계되어 별도 평가 도구를 산출하지 않았다	오프라인 활용 자료(워크시트·활동자료) 개발과 함께 2차년도로 이월
KPI 2 QI 교육콘텐츠 개발	미달(평가도구 일부 미완)	평가도구 3종이 「과정계획안」 산출물 목록에 명시된 단계이며 완성 파일이 확인되지 않는다	강의 완성 시점에 수합. 담당 지영아·이선영
KPI 3 HSS 동영상 제작	미달(제작 진행)	강사 개별 일정에 종속된다. 당초 2026-06 완료 목표에서 지연되었다	사업기간 내 완료를 목표로 촬영·편집 진행
KPI 4 공유대학 탑재	미달(대기)	공유대학 플랫폼의 개설·운영 일정에 종속된다. 사업팀 선행 절차는 2026-04-21 종료되었다	2026-08 이후 탑재
KPI 5 확산 활동	달성	—	—

초과 달성 항목은 없다.

3. 자체 평가

3.1 종합 자체평가표

구분	항목	내용 및 근거
잘된 점	팀 공통 언어의 확립	2025-07-24 킥오프에서 '연구가 아니라 공유 가능한 성과물 개발'이라는 산출 프레임을 공유하고 HSS를 포괄 개념으로 다루는 방향을 논의하고, 2025-09-12 팀장회의에서 도메인을 QI·SDOH 2개로 확정(시스템 사고 제외)하였다. QI 트랙에 SQUIRE 2.0, Flipped Learning+TBL, 압축형 4시간/확장형 8시간 이중 트랙을 적용하기로 하였고(근거 문서: 「HSS QI팀 과정계획안」·2025-11-10 검토의견서), 2026-07-08 포럼에서 "새 과목이 아니라 좋은 진료를 위한 렌즈"라는 대외 설명 언어를 확보하였다.
잘된 점	두 트랙의 설계 완결	SDOH·QI 양 트랙이 모두 K-MedU 표준양식에 따른 개설신청서·계획서를 2026-04-21 제출 완료하였다(2건). 학습 성과는 트랙-모듈-차시 3층으로 매핑되었고(SDOH 학습성과 작업양식), KGO 연계(SDOH: 1 환자진료·2 지식적용과 활용·5 전문직업성 / QI: 1 환자진료·3 소통과 협력)와 KAMC 성과역량 매핑(7.1.1·7.1.2·7.2.2·7.2.3)까지 명시되었다. 교재도 확정되었다(KAMC 번역서 『의료시스템과학』, Skochelak et al. 2021 2nd ed., 이종태 외 2025).
잘된 점	인적·기관 네트워크의 확장	2025-07-24 킥오프 8명으로 출범하여 2025-12-02 신규 연구위원 합류를 거쳐 최종 18인(14개 의과대학) 규모로 확대되었다. 공식 회의 9회(전체회의 5, 팀장회의 3, 워크숍 1)를 운영하였고 연인원 72명이 참여하였다. 2026-04-22 회의에서 각 대학의 HSS 추진 현황이 한 자리에서 공유되었다.
부족한 점	개념 정립이 콘텐츠 개발에 선행하지 못함	한국형 HSS 개념 정립 델파이는 2026-04-22 제5차 전체회의에서 별도 트랙으로 추진하기로 확정하였고 실시 시점은 미정으로, 콘텐츠 설계가 개념 합의보다 앞섰다. 킥오프의 개념 합의는 방향 설정에 그쳤고 조작적 정의는 마련되지 않았다. 그 결과 양 트랙의 설계 단위와 제작 방식이 분화되었다(SDOH=강좌단위·외부 강사 촬영, QI=모듈 단위·내부 촬영, 2026-02-24 팀장회의).
부족한 점	도메인 커버리지의 제한	1차년도가 다룬 도메인은 QI와 SDOH 2개로, HSS 프레임워크 전체 12개 영역(이종태 외, 2021 개념 틀 — 핵심 7·기반 역량 4·연결 1) 대비 일부에 한정된다. 시스템 사고는 2025-09-12 검토 대상에서 제외되었고, SDOH는 범위 재확정으로 5모듈 9차시가 되면서 옹호활동 모듈이 개발 대상에서 빠졌다(이후 촬영 단계에서 한 개 모듈을 2차시로 나누어 촬영하여 최종 10차시). 교수자용 ToT 영상 2강좌도 HSS 오리엔테이션 2개로 대체·연기되었다.

구분	항목	내용 및 근거
부족한 점	효과성 검증의 사업기간 내 불가	콘텐츠 탑재가 2026-08 이후로 확정되어 사업기간 내 학생 사전·사후 데이터 수집이 불가능해졌다. 효과성 평가 연구는 「개발·운영 과정 기록」 중심으로 범위를 축소하고, "성균관대 파일럿 → 다대학 확대"의 단계적 로드맵으로 재구성하였다.
예상하지 못한 성과	대전충청권 포럼을 통한 학계 접점	2026-07-08 제4회 교육부 성과공유세미나 HSS포럼에서 사업팀 발제 2건이 사업 외부 발제 3건(양은배·오윤채·심선희)과 같은 세션에 편성되면서, 한국형 재맥락화의 필요성, Cynefin·빙산 모델, 기존 통합과정을 활용한 저비용 도입 실증, 'Adaptive Systems Citizen' 인제상 등 사업 내부에서 산출되지 않은 언어가 확보되었다. 발제자료 PDF 5건 전량을 확보하여 2차년도 개념 정립 작업의 입력 자료로 사용할 수 있다.
종합 의견	—	1차년도 KPI 판정은 5개 중 1개 완료·3개 진행·1개 대기다. 그러나 산출물의 성격은 아직 설계이며, 탑재·운영·효과 측정은 2차년도로 이월된다. 2차년도의 성패는 (1) 2026-08 이후 탑재와 파일럿 운영, (2) 오프라인 활용 자료 3종의 완성, (3) 델파이를 통한 개념 정립의 소급 보완, (4) 도메인 확장, (5) 상설 조직화에 달려 있다.

3.2 잘된 점

첫째, 팀의 공통 언어가 확립되었다. 킥오프에서 합의한 "연구가 아닌 40개 의대 공유 성과물"이라는 프레임은 1차년도 내내 의사결정의 기준으로 작동하였다. 2025-10-01 제3차 전체회의에서 2025-10-01 제3차 전체회의에서 26개교 수정사업계획서를 분석하여 주차별 콘텐츠 설계에 대한 구체적 제안이 부족함을 확인하였고, HSS를 명시한 9개교를 파악하였다.

둘째, 두 트랙이 설계 수준에서 완결되었다. SDOH는 5개 모듈 10차시(강사 정최경희(이화여대)·윤태호(부산대)·Howard Waitzkin(UNM)·장숙량(중앙대 간호대)·추혜인·어라(살림), QI는 2개 모듈 6차시(Flipped Learning+TBL, 차시별 퀴즈 2문항, 총괄평가 시험 1회·과제 1회)로 구조가 확정되었다. SDOH는 강좌단위, QI는 모듈단위 표준양식을 적용하였다.

셋째, 네트워크가 확장되었다. 11인 TF에서 출발해 최종 18인(14개 의과대학)으로 참여진이 확대되었고, 각 대학의 추진 현황이 공유되었다. 특히 대학별 현황이 "자체 개설 운영 중"(한림), "비교과 개발 의향"(동아), "2학점 선택과목 활용 논의"(부산), "신설 교과 운영"(건국), "6년제 나선형 교육과정 반영"(건양) 등으로 구체적 수준까지 파악되어, 개발물의 수요처가 가시화되었다.

3.3 부족한 점

첫째, 개념 정립이 콘텐츠에 선행하지 못하였다. 이는 일정상 불가피한 선택이었으나, 그 대가는 두 트랙의 설계 언어가 팀별로 분화되고 트랙 간 접합면(HSS 오리엔테이션)이 마지막까지 미확정으로 남은 것이다. QI 모듈1의 HSS Orientation 2개 차시는 2026년 7월 현재 전달 강사가 확정되지 않았다. 2차년도 델파이는 새로운 개념을 만드는 작업이 아니라 이미 만들어진 콘텐츠에 사후적으로 개념적 정합성을 부여하는 작업이 된다는 점을 인식할 필요가 있다.

둘째, 오프라인 활용 자료가 미비하다. 개발물이 영상 중심으로 구성되면서, 대학이 이를 자기 교육과정에 접합할 때 필요한 도구가 부족하다. 부산의대는 2~3학점 확장 활용을 위해 강의 외 워크시트·활동 자료의 동반 개발을 요청하였다. 필수 산출물 3종의 완성이 2차년도 과제다.

넷째, 효과성 검증이 사업기간 내에 이루어지지 못한다. 개발형 과제의 한계이기도 하나, 결과적으로 1차년도 보고 가능한 근거는 산출물과 과정 기록에 한정된다.

3.4 예상하지 못한 성과

이 구조가 확인된 자리가 2026년 7월 31일 성과 공유 워크숍이다. 18명·13개 기관이 모여 개발 중인 Phase 0~3 사례를 공유하였고, 참석자 18명 중 10명이 본 과제 연구진이었다. 즉 동일한 인력이 두 사업의 콘텐츠를 나누어 개발하고 한자리에서 합친 형태다. 이 자리에서 시스템 사고 트랙 교안의 참조 포맷과 워크시트 2벌 제작 방침이 정해졌다(실물 배포는 워크숍 이후). 본 과제 SDOH·QI 콘텐츠는 이미 2026-04-21에 K-MedU 표준양식으로 제출되었으므로, 두 트랙의 규격 통일 은 2차년도 과제로 남는다.

또한 2026-07-08 대전충청권 포럼은 사업 내부 논의가 학계의 검증 언어와 접촉한 첫 계기였다. 사업팀이 스스로 생산하지 못한 개념적 자원을 외부 발제로부터 확보하였다는 점에서, 대외 발표를 성과 홍보가 아니라 개념 조달의 경로로 활용할 수 있음을 확인하였다.

3.5 종합 의견

1차년도 KPI 5개 중 1개 완료, 3개 진행, 1개 대기다. 산출은 설계·설계문서·합의 형태에 한정된다. 영상 16차시는 촬영 중, 평가도구 3종은 목록 단계이며 K-MedU 탑재는 2026년 8월 이후다.

이에 따라 2차년도(또는 잔여 기간) 우선 과제를 다음과 같이 제시한다.

1. 탑재와 파일럿 운영: 2026-08 K-MedU 탑재 후 성균관의대 파일럿을 우선 실행하고, 운영 기록을 효과성 평가 연구의 1차 데이터로 축적한다.

2. 오프라인 활용 자료 완성: TBL 활용지(IRAT/GRAT), SQUIRE 2.0 체크리스트·루브릭(학생용/교수자용), QI 프로젝트 RFP 양식 3종을 완성하여 대학의 학점화 요구에 대응한다.

3. 개념 정립의 소급 보완: 한국형 HSS 델파이(2027-01 예정)를 통해 개발된 콘텐츠에 개념적 정합성과 용어 표준을 부여한다.

4. 도메인 확장과 규격 통합: 2026-07-31 워크숍에서 공유된 건양대 시스템 사고 콘텐츠와 총론 모듈을 K-MedU 규격으로 정리해 사업 산출물 체계에 편입하는 방안을 건양대와 협의하고(현재 편입 합의 근거 없음), SDOH 축소 과정에서 제외된 옹호활동 모듈의 회수 경로를 검토한다.

5. 조직의 상설화: 2026-02-24 팀장회의에서 논의된 상설 조직화 이사장 건의 방침을 진행하여, 1차년도에 형성된 18인 규모의 개발진과 14개교 네트워크가 사업 종료와 함께 해체되지 않도록 한다.

07 성과 확산 및 활용 방안

본 과제는 2025년 7월 24일 킥오프 회의에서 "연구가 아니라 40개 의과대학이 공유할 성과물을 만든다"는 프레임으로 출발하였다. 다만 1차년도 종료 시점(2026년 8월 31일)에서 확산의 실제 국면은 아직 시작되지 않았다. 강의 콘텐츠 16개 차시는 설계·강사 배치·과업 범위가 확정되고 촬영이 진행 중인 단계이며, 공유대학(K-MedU) 플랫폼 탑재는 2026년 8월 이후로 예정되어 있다. 즉 본 장은 그 기반이 무엇이고 어디에 쓰이는지, 그리고 사업 종료 이후 누가 무엇으로 유지하는지를 기술한다.

1. 전국 의과대학 보급·확산 방안

가. 확산 경로 종합

확산 대상	확산 방법(매개 산출물)	시기	기대 효과
전국 의과대학(공유대학 참여교)	K-MedU 탑재 강의 영상 16개 차시 — SDOH 10차시(5모듈)·QI 6차시(2모듈), 차시당 25~35분	범위 확정 2026-04-22 / 촬영 당초 2026-06 목표(지연) / 플랫폼 탑재 2026-08 이후	개별 대학이 자체 개발 없이 HSS 2개 도메인의 온라인 콘텐츠를 확보
교육과정 설계·심의 주체(교무위원회·교육과정위원회)	표준 교육설계 문서 2건 — (통합)강의·모듈 개설신청서 + 강의·모듈 계획서 × 2트랙, K-MedU 표준양식 준수	2026-04-21 제출 완료	학점·차시·평가 구조를 그대로 이식하거나 자교 사정에 맞게 재구성할 수 있는 설계 원본 제공
HSS 담당 교수자	교수자용 ToT 설계안 1건 — 「HSS QI팀 과정계획안」 5장, 권장 6시간(블록 A·A'·B·C·D·E·F, 교수자 전용 신규개발 A'·E·F 3시간)	설계 확정 2025-12-12(제4차 전체회의 [첨부6.1]) / 영상화는 2026-04-22 결정으로 연기	콘텐츠 시청형 확산을 넘어 대학이 자체 운영할 수 있는 역량 이전 경로 확보
실습·평가 운영 담당 교수	평가·실습 도구 3종 — TBL 활용지(IRAT/GRAT), SQUIRE 2.0 체크리스트·루브릭(학생용/교수자용), QI 프로젝트 RFP 양식	산출물 목록 확정(과정계획안 6장) / 실물 개발 진행 중	온라인 시청에 오프라인 실습·평가를 결합한 혼합형 운영 가능
의학교육 학술공동체	대외 발표 2회 — 2025-11-14~15 KAMC Annual Meeting 중간발표 / 2026-07-08 제4회 교육부 성과공유세미나 대전 충청권 HSS포럼(5개 발제 중 사업팀 2건: 최용준·이승희)	완료	진행 상황의 공개 검증과 한국형 재맥락화 언어("새 과목이 아니라 좋은 진료를 위한 렌즈") 확보
후속 연구 커뮤니티	연구 2트랙 — ① 공유 교육과정 효과성 평가(제안 김세진) ② 한국형 HSS 개념 정립 델파이(제안 김강철). 시스템 사고 교육모델 연구(제안 천경희)는 건양의대 주관 협력 연구	계획 확정 2026-04-22 / 실행은 사업 종료 후 이월(델파이 2027-01 예정)	확산 이후의 효과와 개념 정의를 근거로 축적

나. 확산 단위: 과목이 아니라 차시

본 과제의 산출물은 "HSS 과목 한 벌"이 아니라 독립 시청이 가능한 25~35분 단위 차시로 설계되었다. 이는 대학마다 HSS 진입 지점이 다르다는 현실을 반영한 결정이다. 2026년 4월 22일 5차 전체회의에서는 QI 트랙에 대해 모듈 1(HSS 오리엔테이션 2차시)은 의예과, 모듈 2(QI 심화 3차시)는 본과 고학년으로 분리하면 "학년을 달리해 다양한 교과에서 활용 가능"하다는 제안이 제기되었고, 분리안은 QI 개발팀 검토 후 확정하기로 하였다. 확산의 최소 단위를 차시로 잡을 때 대학은 (1) 16개 차시 전체를 하나의 선택과목으로 개설하거나, (2) 필요한 모듈만 기존 과목에 삽입하거나, (3) 비교과·자유선택 프로그램으로 운영하는 세 가지 경로를 모두 선택할 수 있다.

다. 강의 콘텐츠 단독 확산의 한계

부산의대는 2026년 4월 22일 현황 공유에서 "강의 외 워크시트·활동 자료를 함께 개발해 달라"고 요청하였다. 2~3학점 규모로 확장 활용하려면 영상만으로는 수업 시간을 채울 수 없다는 실무적 지적이다. QI 트랙은 이미 Flipped Learning + TBL 구조와 실습 도구 3종을 설계에 포함하고 있으나, SDOH 트랙은 "교안 외 오프라인 활용 자료 여부는 강사와 개별 논의 필요"(2026-04-22) 단계에 머물러 있다. 강의 영상과 활동 자료의 비대칭은 2차년도 확산에서 우선 해소해야 할 항목이다.

라. 대외 확산 채널

2026년 7월 대학별 의학교육 포럼 일정이 공유되었다(부경 7/1, 제4회 교육부 성과공유세미나 대전충청권 HSS포럼 7/8, 건양의대 7/15, 동아의대 7/16 — 2026-04-22 제5차 전체회의 공유). 이 가운데 사업 성과 발표가 확인된 것은 7월 8일 대전충청권 HSS포럼이다.

7월 31일~8월 1일 워크숍은 이와 성격이 다르다. 외부에 성과를 알리는 자리가 아니라 개발 주체들이 산출물을 맞추는 자리였고, 시스템 사고 트랙 교안의 참조 포맷과 워크시트 2벌 제작 방침이 이 자리에서 정해졌다. 1일차 18명이 모인 규모는 1차년도 중 최대이며, 2일차에는 HSS를 독립 교과로 신설할 것인가 기존 교과에 모듈로 편입할 것인가가 쟁점으로 제기되었고 합의에는 이르지 않았다. 2026-08-01 식사 자리 대화에서 정기 워크숍 루틴화가 거론되었으나 의결되지 않았다.

2. 대학별 적용 사례

아래는 2026년 4월 22일 5차 전체회의 「각 대학 HSS 교육 추진 상황 공유」와 2026년 8월 1일 워크숍 대학별 현황 라운드테이블에서 공유된 12개교의 적용 현황·계획이다. (8/1) 표기는 워크숍에서 공유된 내용이다.

대학	적용 내용	시기
한림의대	2024년부터 「의료시스템과학」 과목 자체 개설(전신: 2023년 「의료의 사회적 맥락」), 1주일 단위 운영. 예방 의학·사회의학 2인 + 임상교수 복수 + 의학교육학 2인 참여. (8/1) 임상실습 전 1주로 확대	운영 중
인제의대	교내 HSS 과제 없음. SDOH 외부 강사(정최경희·윤태호·장숙량·추혜인·어라·Howard Waitzkin) 섭외 창구 역할	개발 기간 중
동아의대	혁신사업 계획서에 "KAMC 중앙 개발 시 비교과로라도 활용·운영" 기술. 비교과 1개 개발 의향(예방의학·의학 교육학·의료인문학 3개 교실 공동). (8/1) 「자유선택과정」을 활용한 HSS 개론 또는 시스템 사고 과정 운영 검토	시기 미확정
충남의대	의료인문학교실 2026년 3월 첫 개설. 단독 주도 개발 계획 없음, 공유 프로그램 개발 시 활용 예정(의료인문학교실+의학교육학교실 담당). (8/1) 인문사회의학 1~7 운영, 공유 콘텐츠 적용 지점으로 「의료와 사회」 차 시 우선 검토	2026-03 이후
부산의대	계획서에 "KAMC 개발 시 적극 활용" 기술. 의학과 대상 2학점 선택과목 활용 논의 중. 워크시트·활동 자료 동반 개발 요청(2~3학점 확장 목적). 공유대학팀으로서 K-MedU 양식 배포·품질 심사 총괄	논의 중
서울의대	6년제 위원회에 HSS 포함 결정, 수업 준비 중	준비 중
건국의대	2026년 「지역사회의학」 신설(의전원→의대 전환에 따른 부활). 대상 예과 1학년·본과 1학년, 주제는 건강의 사회적 결정요인, 5월 첫 강의 + 학생 액티비티·실습 운영	2026-05 개시
성균관의대	나선형식 교육과정 내 교육내용으로 운영. 「지역사회진료현장실습」·「의학입문」 교과목에서 HSS 내용을 주요하게 다루고 있으며, 사회의학교실 및 의학교육학교실에서 교육과정 검토 진행 (8/1 재확인)	운영 중 / 검토 예정
건양의대	6년제 조기 도입(6년 나선형 교육과정). HSS 주요 내용이 예방의학·의학교육학 과목에 이미 분포하여 모듈 개발 시 기존 교육과정에 안착 가능. 교내 스튜디오 전문 교수진 10인 양성(2026-06말 목표), 시스템 사고 콘텐츠 개발 진행 중 2026-07-31 성과 공유 워크숍 주최(18명·13개 기관), HSS 총론(오리엔테이션) 모듈 1~2개를 사업팀과 공동 개발. (8/1) 교과 신설 대신 기존 교과 편입 전략 — 시스템 사고 콘텐츠를 모듈화하여 5학년 의사소통·1학년 교과에 삽입, 의학교육 전문위원 8명 HSS 교과서 스터디 운영	2026 상·하반기

대학	적용 내용	시기
아주의대 (8/1)	인구보건 1~3 편성, 지역사회의학 실습·임상의료윤리 등 운영. HSS 소위원회 신설(2024) 후 올해 「HSS 인문 사회의학 소위원회」로 개칭	운영 중
가톨릭관동의대 (8/1)	미운영. 본과 1학년 「의사소통 1」에 시스템 사고 시범 적용. 월 1회 교수개발 시간 활용 검토	시범 적용

주) 연구팀 소속인 경희의대(임윤주)·전남의대(조용수)·울산의대(강동윤)·경북의대(강지연)는 두 자리 모두에서 현황 발표가 없어 이 표에 포함하지 않았다. 차의과 학대 의전원·가톨릭관동의대는 연구진 소속교는 아니나 워크숍에서 현황을 공유한 협력 대학이다. 참여 대학 14개교 산정은 연구진 명단 기준이며(IV장 2절), 이 표의 대학 수와는 기준이 다르다.

가. 적용 유형의 분화

위 대학들의 계획은 세 가지 유형으로 나뉜다.

- 기존 과목 삽입형: 성균관의대, 건양의대, 건국의대, 충남의대, 서울의대(6년제 개편 연계), 아주의대(인구보건·지역사회의학 실습 운영), 가톨릭관동의대(「의사소통 1」 시범 적용)
- 비교과·선택 활용형: 동아의대(비교과 1개, 자유선택과정 소그룹)

콘텐츠를 "차시 단위 + 모듈 단위"로 이중 편성하고, SDOH는 강좌단위, QI는 모듈단위 K-MedU 양식으로 제출하였다(2026-04-21).

나. 1차년도 적용 현황의 정직한 진단

현황이 공유된 대학 가운데 본 과제의 산출물을 정규 교육과정에 확정 배치한 대학은 확인되지 않는다. 대부분 "활용 예정", "논의 중", "검토 예정" 단계이며, 이는 콘텐츠 탑재가 2026년 8월 이후로 예정되어 있는 이상 불가피하다. 한림·건국·성균관·건양·아주는 사업 산출물과 무관하게 이미 HSS 성격의 수업을 운영하고 있다.

3. KAMC 플랫폼·타 과제 연계 방안

가. 공유대학(K-MedU) 탑재

탑재 경로는 다음과 같이 확정되었다. 공유대학팀(부산의대 임선주·최효선 교수)이 배포한 K-MedU 강의개발계획서 표준양식 2종(강좌단위/모듈단위, 2025-12-01 배포용3)을 2025년 12월 2일 팀장회의에서 준수하기로 결정하고, 2026년 2월 24일 팀장회의에서 "양식 수정 요청 없이 그대로 활용하고 팀별 기존 설계안을 양식에 맞춰 변환한다"는 방침을 확정한 뒤, 2026년 4월 21일 두 트랙의 최종안을 제출하였다.

구분	SDOH 트랙	QI 트랙
과정명	건강의 사회적 결정요인(Social Determinants of Health)	환자안전을 위한 질향상/질관리(Quality Improvement for Patient Safety)
개설 단위	강의(강좌) 단위	모듈 단위(다중모듈 2개)
구성	5모듈 10차시(제출본은 개정 전 6모듈 14차시 + 평가 1차시 = 15차시 1학점 기준)	2모듈 6차시
대상	학부 임상실습	학부 임상실습전·임상실습
운영 형태	100% 온라인(온·오프라인 혼합 여부는 강사 논의 후 결정)	온·오프라인 혼합, Flipped Learning + TBL
평가	평가 1차시(원안 기준)	총괄평가(시험 1회·과제 1회) + 형성평가(차시별 퀴즈 2문항)
교재	강의 슬라이드, Skochelak et al.(2021, 2nd ed.), 이종태 외(2025) 번역서	KAMC 번역서 『의료시스템과학: 의학교육 변화를 위한 이니셔티브』
관련 KGO	1(환자진료)·2(지식적용과 활용)·5(전문직업성)	1(환자진료)·3(소통과 협력)
운영 인력 요건	—	운영책임 권장 교수 3명 + 강좌조교 1명(예방의학·의학교육 분야)

탐재 전 정리가 필요한 사항은 SDOH 설계문서의 개정 한 가지다. 제출본(2026-04-21)은 축소 전 6모듈 14차시 기준이고 확정 범위(5모듈 10차시)를 반영한 개정본은 작성되지 않았다(2026-08-02 확인). 한편 차시 길이 규격은 25~35분으로 확인되어 공유교육 원칙(30~35분, 15분 2 package 편성)과 상충하지 않는다.

나. 시민성 교육과정(세부과제 2번)과의 연계 — SDOH 옹호활동 모듈

SDOH 트랙 원안의 「건강 불형평 해소를 위한 옹호활동」 모듈(3차시, 김새롬+조용수)은 2026년 4월 22일 과업 범위 재확정으로 개발 대상에서 제외되었다. 다만 제5차 전체회의는 이 모듈을 이번 콘텐츠에서만 제외하고 시민성 교육 등 다른 파트에 포함할 가능성을 검토하기로 논의하였다. 즉 옹호(advocacy)는 폐기된 것이 아니라 연계 대상으로 이관 검토 중인 항목이다.

연계의 근거는 세 가지다. (1) 옹호활동은 시민성 교육과정이 다루는 공공선·건강 형평성 영역과 개념적으로 중첩되어, 양 과제가 각각 개발할 경우 중복 투자가 발생한다. (2) 두 과제 모두 K-MedU 탐재를 전제로 하므로 학습자 입장에서는 동일 플랫폼 내 인접 콘텐츠가 된다. (3) 인적 접점이 이미 존재한다 — 이승희 교수(서울의대 의학교육학)는 KAMC 상위 사업 접점이자 2026년 7월 8일 대전충청권 HSS포럼 발제자이다. 다만 연계의 구체적 방식(공동 개발/상호 참조/교차 링크 중 무엇인지)은 아직 합의되지 않았다.

다. KAMC 조직·사업 차원의 연계

연계 대상	연계 내용	현재 단계
공유대학팀(부산의대)	K-MedU 양식·품질 심사·플랫폼 운영	설계문서 제출 완료(2026-04-21), 심사·탐재 대기
시민성 교육과정 과제	SDOH 옹호활동 모듈의 이관 검토	가능성 검토 합의(2026-04-22)
KAMC 졸업성과(KGO) 체계	SDOH → KGO 1·2·5 / QI → KGO 1·3, QI 과정계획안은 KAMC 성과역량 7.1.1·7.1.2·7.2.2·7.2.3 매핑	매핑 완료
KAMC 조직	상설 조직화 이사장 건의 방침(2026-02-24 팀장회의)	방침 확정

교재로 KAMC 번역서가 지정되고, 성과역량 매핑이 KAMC 체계를 따르며, 플랫폼이 KAMC 공유대학이라는 점에서 본 과제의 산출물은 이미 협회 인프라에 결박되어 있다. 이는 확산의 제도적 근거인 동시에, 협회 차원의 관리 주체가 정해지지 않으면 유지가 불가능하다는 뜻이기도 하다.

4. 지속 가능성 확보 방안

가. 운영 주체 및 관리 체계

1차년도 운영 체계는 팀장(최용준) 총괄 아래 SDOH 팀장(김세진)·QI 팀장(지영아) 2트랙 체제와 간사(김강철)로 구성되었고, 공식 회의 9회(전체회의 5회, 팀장회의 3회, 워크숍 1회)를 통해 운영되었다. 사업팀 회의록 명단 기준 누적 연인원은 72명이다.

문제는 콘텐츠의 운영·유지 국면이 과제 조직의 존속 기간 밖에서 시작된다는 점이다. 탑재가 2026년 8월 이후이므로, 실제 사용·피드백·개정이 발생하는 시점에는 1차년도 조직이 이미 해산되어 있다. 2026년 4월 22일 5차 전체회의에서 "사업 종료(8월) 이후 HSS 팀 활동 방향"과 "7~8월 중 오프라인 결산 및 발전 방향 논의"가 안건으로 제기되고 오프라인 결산 모임 추진이 합의된 것은 이 공백을 사업팀이 인지하고 있음을 보여준다. 이 결산 모임은 2026년 8월 1일 워크숍 2일차로 실행되어 1차년도 경과 보고와 2차년도 이후 조직 형태 논의(연구회·네트워크 구성 후 회장 선출을 통한 운영 이관)로 이어졌다. 다만 해당 논의는 워크숍 종료 후 식사 자리의 자유 대화였고 안건 상정·의결 절차는 없었으므로, 방향 표명 수준으로 기술한다.

기능	1차년도 담당	근거	종료 후 이관·유지 방안
과제 총괄·대외 대표	팀장(최용준)	사업 조직	미정
트랙별 콘텐츠 책임	SDOH 김세진 / QI 지영아	2025-09-12 팀장 배치	미정
회의·문서 관리	간사(김강철)	회의록 9회	미정
플랫폼 운영·품질 심사	공유대학팀(부산의대 임선주·최효선)	K-MedU 양식 배포·심사	미정
후속 연구	연구 2트랙 연구진	2026-04-22 공식화	미정

이관에서 가장 먼저 확정해야 할 것은 개정 권한의 소재다. 콘텐츠 소유 주체가 불명확하면 표준이 바뀌어도 아무도 고치지 않는 상태가 발생한다.

나. 지속 가능성 저해 요인과 대응

저해 요인	구체적 내용
관리 공백	탐재(2026-08 이후)와 사업 종료(2026-08-31)가 겹쳐, 운영 개시 시점에 책임 조직이 부재
근거 부재	사업기간 내 학생 pre-post 데이터 수집 불가
개념 미합의	한국에 합의된 HSS 개념이 부재하여 대학마다 범위 해석이 상이
교수자 부족	ToT 영상 미제작, 대학별 3+1 인력 요건
자료 비대칭	SDOH는 활동 자료 미설계, QI는 실습 도구 미완성
문서 불일치	SDOH 제출본(6모듈 14차시)과 확정 구성(5모듈 10차시)의 차이 등

08 추진 과정의 쟁점·애로사항 및 개선 방안

본 장은 1차년도 추진 과정에서 실제로 발생한 쟁점과 그 대응을 기술한다.

1차년도의 쟁점은 크게 두 종류로 나뉜다. 하나는 산출 일정과 편성 여건에서 비롯된 범위 조정의 문제(①③)이고, 다른 하나는 HSS라는 개념 자체가 국내에서 아직 정착되지 않은 데서 비롯된 구조적 문제(②④⑤⑥)다. 전자는 1차년도 내에 해소되어 최종 16차시(SDOH 10 + QI 6) 범위로 수렴되었으나, 후자는 사업 종료 이후로 이월되는 성격을 가진다.

구분	쟁점	원인	대응
제도	② 개념 정립과 콘텐츠 개발의 시간 역전 — 한국 맥락에서 HSS의 범위·구성요소에 대한 학문공동체 합의가 이루어지기 전에 콘텐츠 개발이 선행됨. 한국형 HSS 개념 정립 델파이는 2027-01 예정인 반면 콘텐츠 촬영 완료 목표는 2026-06	사업 성격이 2025-07-24 킥오프에서 '연구가 아닌 40개 의대 공유 성과물'로 설정되어 산출 일정이 개념 합의보다 앞섬	킥오프에서 HSS를 포괄 개념으로 다루자는 제안이 제기됨(2025-07-24). 2026-07-08 대전충청권 HSS포럼 5개 발제를 통해 '새 과목이 아니라 좋은 진료를 위한 렌즈', 한국형 재맥락화 필요성 등 설명 언어를 확보. 2026-04-22 제5차 전체회의에서 델파이를 연구 2트랙 중 하나로 공식화.
현장 운영	④ 개발자-강의자 분리 구조의 의사소통 — 설계 주체(개발진)와 전달 주체(강사)가 분리되어 학습성과-차시 내용의 정합성 관리 부담이 발생. QI 트랙 HSS 오리엔테이션 2개 차시는 전달 강사 미확정. 문서 간 기록 편차도 확인됨(QI 개발참여자 성명 '정수민'/'정승민' 표기 불일치 → 「과정계획안」 원문에 따라 '정승민'으로 확정, 교수자용 ToT '권장 6h'와 하단 합계 '총 7h' 병기 → 각각 권장 운영 시수와 전체 블록 합계로 정리)	공유 콘텐츠의 특성상 개발 주체와 강의 주체가 일치하지 않으며, 9회에 걸친 회의 결정사항이 복수 문서에 분산 기록됨	「HSS-SDOH 학습성과 및 목표 작업양식(2025-11-10 수정본)」으로 트랙-모듈-차시 3층 학습성과 매핑을 확정(2025-12-02 팀장회의 [첨부5]). K-MedU 표준양식 기반 설계문서 2건을 2026-04-21 제출하여 두 트랙의 설계 언어를 통일.
제도	⑤ 대학별 HSS 인식·준비도 편차 — 자체 정규 과목을 이미 운영하는 대학(한림, 2024년 '의료시스템과학' 개설)부터 신설 검토(서울·건국·성균관), 비교과 활용 의향(동아), 미도입까지 도입 단계가 넓게 분포. 2025-10-01 제3차 전체회의에서 26개교 중 HSS를 명시한 곳은 9개교였고, 대부분 체계 중심 설계에 그쳐 주차별 콘텐츠 제안은 부족한 것으로 공유됨	HSS 용어·범위에 대한 공통 기준이 없고, 관련 내용이 예방의학·의료인문학·의학교육학 등 기존 교과목에 분산 배치되어 대학별 출발점이 상이	2026-04-22 제5차 전체회의에서 대학별 추진 현황 공유를 정례 안건으로 운영. 활용 단위를 SDOH = 강좌 단위, QI = 모듈 단위로 이원 설계하여 정규 교과·비교과·선택과목 어디에도 삽입 가능하도록 함.
인력·보상	⑥ 참여진의 시간 자원 한계 — 참여진 대부분이 임상·기초 교실 본무를 병행하며, 개발 실무가 트랙별 소수(팀장 겸 개발 담당 각 1인)에게 집중. QI 소위 2차(2025-11-10)는 일정 조율이 어려워 검토의견서 회람으로 진행	전임 인력 없이 겸직 위원 구조로 운영되는 가운데, 회의 9회·연인원 72명 규모의 일정 조율 부담이 누적	전체회의(5회)-팀장회의(3회)-도메인 소위(2회)의 3층 회의 구조로 결정 단위를 분산하고, 회의 개최가 어려운 사안은 문서 회람으로 병행 처리.

2차년도·후속 방향

강의 탑재와 실제 수강을 추진하고, 오프라인 활동자료·평가도구를 보완합니다. 공유 교육과정 효과성 및 한국형 HSS 개념 정립을 후속 연구로 연결합니다.